AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 08 · HO · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

HEMATOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

56	20	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 08

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 08 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 32

Índice por tipo de imagen 35

Soluciones de la autoevaluación 38

Signos con nombre propio 34

Autoevaluación 36

01 Síndromes Anémicos Hipoproliferativos y Carenciales

8.1 Síndrome Anémico

01 Frotis de sangre periférica normal 4
02 Microcitosis e hipocromía 4
03 Esferocitos 5

8.3 Anemia Ferropénica

04 Coiloniquia 5
05 Queilitis angular 6
06 Glositis atrófica 6
07 Frotis de anemia ferropénica 7

8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

08 Médula ósea normal 7
09 Aplasia medular 8
10 Petequias y púrpura 8

02 Anemias Macrocíticas, Hemolíticas y Hemoglobinopatías

8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas

11 Frotis megaloblástico 9
12 Degeneración combinada subaguda 9
13 Glositis de Hunter 10

8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI

14 Prueba de Coombs directa e indirecta 10
15 Ictericia flavínica 11
16 Fenómeno de Raynaud 11
17 Autoaglutinación por crioaglutininas 12

8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

18 Patogenia de la esferocitosis 12
19 Colelitiasis pigmentaria 13
20 Déficit de G6PD: célula mordida 13
21 Cuerpos de Heinz 14

8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

22 Cuerpos de hemoglobina H 14
23 Dianocitos 15
24 Cráneo en cepillo 15
25 Cuerpos de Howell-Jolly 16

8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT)

26 Esquistocitos 16
27 Esquistocitos abundantes 17

03 Hemostasia Primaria, Plaquetas y Coagulopatías

8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio

28 Cascada de la coagulación y sus exámenes 17

8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño

29 Pseudotrombocitopenia por EDTA 18

8.13 Coagulopatías Congénitas

30 Artropatía hemofílica 18
31 Hematoma del psoas en la TAC 19

8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

32 Púrpura en una sepsis (CID) 19

04 Oncohematología: Neoplasias Mieloides y Linfoides

8.16 Leucemias Agudas

33 Infiltración gingival 20
34 Linfoblastos 20
35 Blastos tipo Burkitt 21

Índice por tema · continuación

8.17 Leucemias Crónicas

36 Sombras de Gümprecht 21
37 Leucemia mieloide crónica 22
38 Leucemia linfática crónica 22
39 Esplenomegalia masiva 23

8.18 Linfomas

40 Adenopatía supraclavicular 23
41 Célula de Reed-Sternberg 24
42 Linfoma MALT gástrico 24

8.19 Mieloma Múltiple

43 Electroforesis: pico monoclonal 25
44 Lesiones líticas del mieloma 25
45 Pilas de monedas (rouleaux) 26

8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

46 Facies pletórica 26
47 Eritromelalgia 27
48 Trombocitemia esencial 27
49 Dacriocitos 28
50 Neutrófilo pseudo-Pelger-Huët 28

05 Urgencias Oncohematológicas, Trombofilias y Medicina Transfusional

8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

51 ECG de hiperkalemia 29
52 Compresión medular por metástasis 29

8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF

53 Necrosis cutánea por cumarínicos 30
54 Livedo reticularis 30

8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes

55 TRALI 31
56 TACO 31

01 TEMA 8.1 · SÍNDROME ANÉMICO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

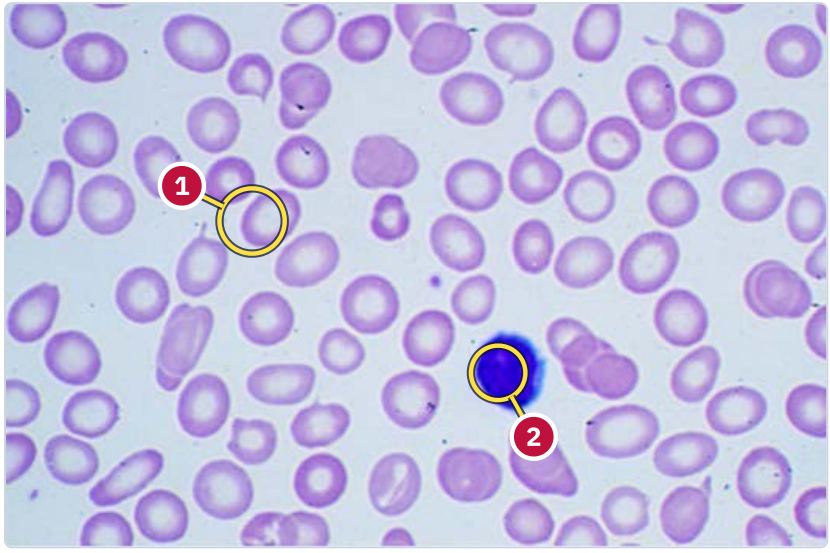


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., p. 467

QUÉ TIENES QUE VER

1. Glóbulo rojo normal con palidez central
2. Linfocito

DIAGNÓSTICO

Frotis de sangre periférica normal

Glóbulos rojos del mismo tamaño, con palidez central de un tercio.

CONDUCTA INICIAL

Los reticulocitos dicen si la médula responde: requieren tinción supravital.

`1.08.4.008` **Hemograma** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Microcitosis: glóbulos más chicos que el núcleo del linfocito.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 6** Tema 8.1

Clase 8.1 en video

02 TEMA 8.1 · SÍNDROME ANÉMICO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

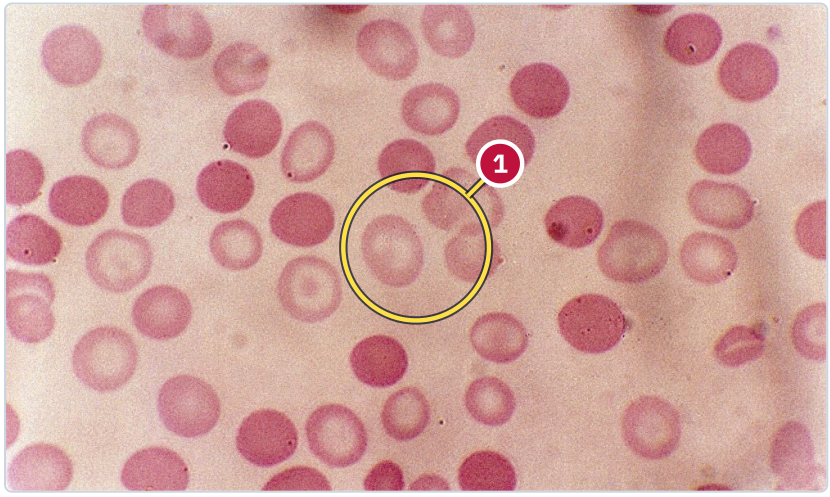


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 16

QUÉ TIENES QUE VER

1. Glóbulos pequeños con palidez amplia

DIAGNÓSTICO

Microcitosis e hipocromía

Glóbulos pequeños y pálidos.

CONDUCTA INICIAL

Microcítica arregenerativa: ferropenia, rasgo talasémico o sideroblástica; ferritina primero.

`1.08.1.002` **Anemia ferropénica** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`1.08.4.008` **Hemograma** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Rasgo talasémico: microcitosis con RDW normal.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 6** Tema 8.1

Clase 8.1 en video

03 TEMA 8.1 · SÍNDROME ANÉMICO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

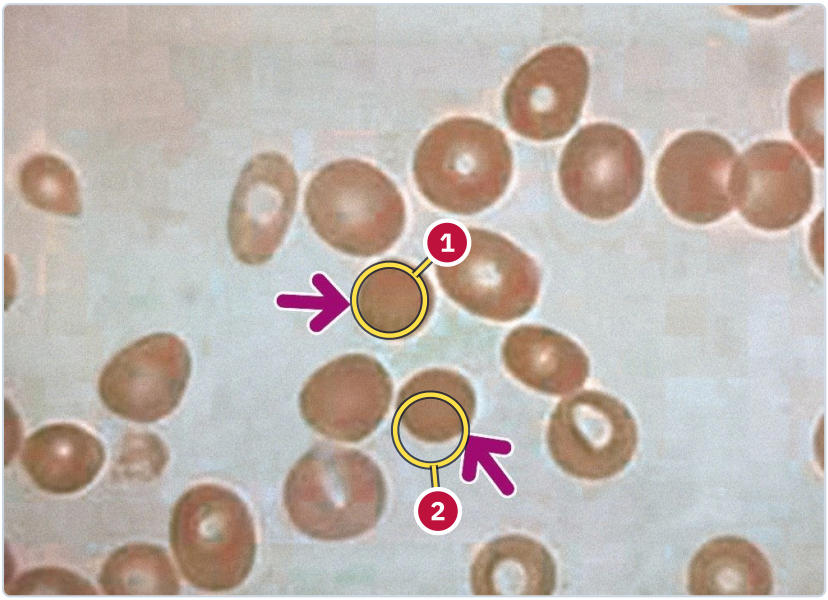


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 34

QUÉ TIENES QUE VER

1. Esferocito
2. Esferocito

DIAGNÓSTICO

Esferocitos

Glóbulos pequeños, redondos y sin palidez central (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Coombs directo: positivo en la AHAI; negativo en la esferocitosis hereditaria.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Microcitos ferropénicos: pálidos, no densos.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P21** «Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen físico solo muestra ictericia de escleras y…» → **Hemólisis**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 7** Tema 8.1

Clase 8.1 en video

04 TEMA 8.3 · ANEMIA FERROPÉNICA

FOTO CLÍNICA

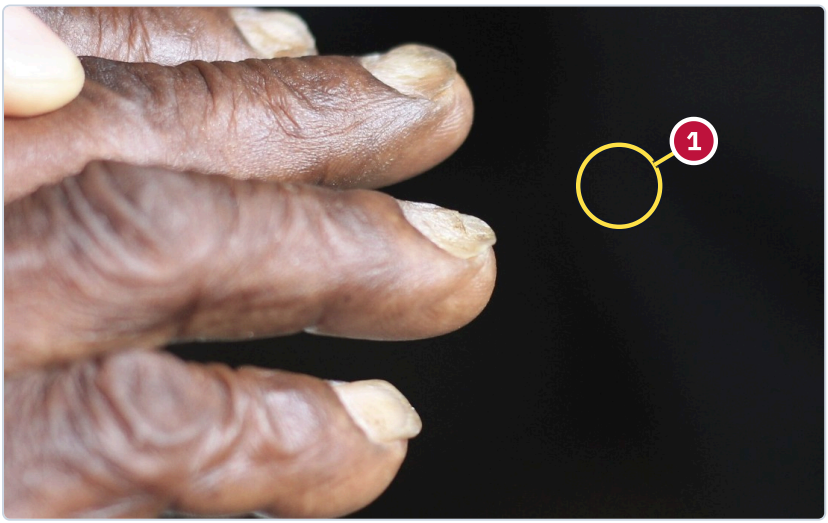


Imagen: Wikimedia Commons «Koilonychia iron deficiency anemia.jpg», CC BY 2.0, CHeitz

QUÉ TIENES QUE VER

1. Uña cóncava

DIAGNÓSTICO

Coiloniquia

Uñas en cuchara: signo clásico de la ferropenia.

CONDUCTA INICIAL

Ferritina baja confirma; buscar la causa (digestiva, menstrual, celíaca).

1.08.1.002 Anemia ferropénica

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Platoniquia: uña plana sin concavidad.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P27** «Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico…» → **Administrar hierro por vía endovenosa**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 12** Tema 8.3

Clase 8.3 en video

05 TEMA 8.3 · ANEMIA FERROPÉNICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Fisura de la comisura
2. Fisura de la comisura

DIAGNÓSTICO

Queilitis angular

Grietas en las comisuras de la boca.

CONDUCTA INICIAL

Ferropenia: hierro oral; EV si no tolera o hay malabsorción.

1.08.1.002 Anemia ferropénica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Candidiasis comisural: también en diabéticos y portadores de prótesis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 13** Tema 8.3

Clase 8.3 en video

06 TEMA 8.3 · ANEMIA FERROPÉNICA

FOTO CLÍNICA

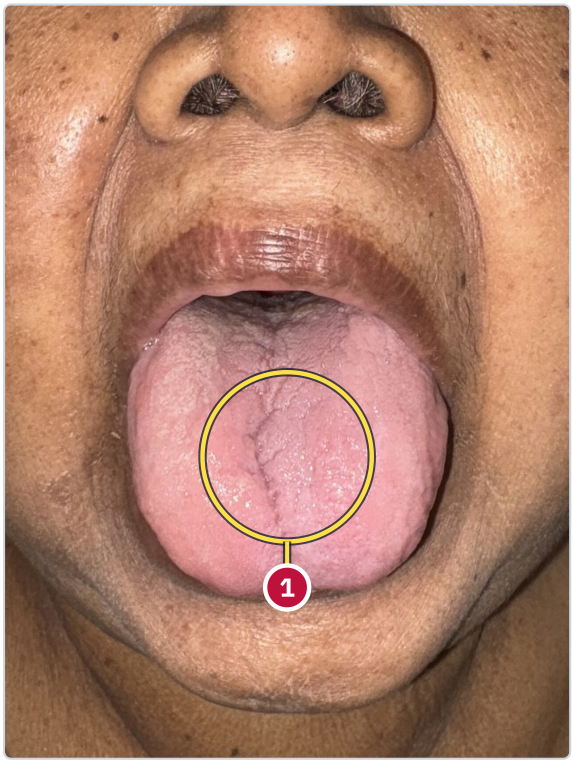


Imagen: Wikimedia Commons «Glossitis in Iron-deficiency Anaemia, a Thai female patient (2025).jpg», CC BY 4.0, Chainwit.

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lengua depapilada

DIAGNÓSTICO

Glositis atrófica

Lengua lisa y dolorosa, sin papilas.

CONDUCTA INICIAL

Ferropenia o déficit de B12: pedir ferritina y B12.

1.08.1.002 Anemia ferropénica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.08.1.004 Anemia megaloblástica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Lengua geográfica: placas que cambian de lugar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 12** Tema 8.3

Clase 8.3 en video

07 TEMA 8.3 · ANEMIA FERROPÉNICA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

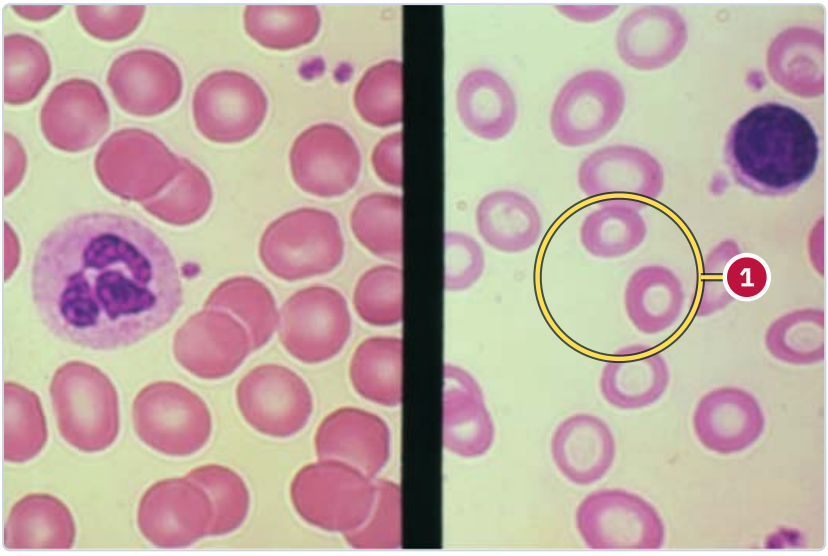


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Glóbulos pequeños e hipocrómicos

DIAGNÓSTICO

Frotis de anemia ferropénica

Microcitosis, hipocromía marcada y anisocitosis.

CONDUCTA INICIAL

RDW alto orienta a ferropenia; ferritina < 30 la confirma.

1.08.1.002 **Anemia ferropénica**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Anemia de enfermedad crónica: ferritina normal o alta.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P58 «Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento per- manente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento...» → **Anemia por enfermedades crónicas**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 12
Tema 8.3

Clase 8.3 en video

08 TEMA 8.5 · APLASIA MEDULAR E HIPOFUNCIÓN MEDULAR ADQUIRIDA VS FÁRMACOS MIELOTÓXICOS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

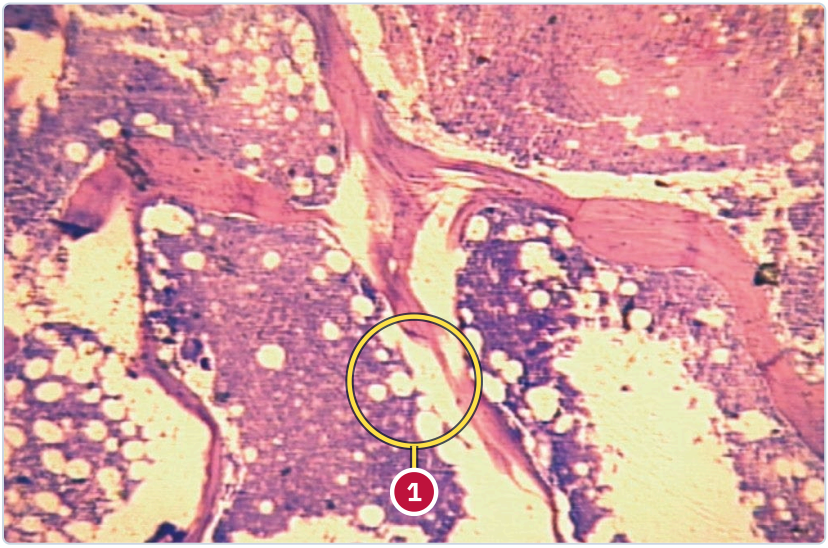


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Celularidad hematopoyética

DIAGNÓSTICO

Médula ósea normal

Biopsia normocelular: células y grasa en proporción.

CONDUCTA INICIAL

Celularidad normal ~ 100 menos la edad.

1.08.4.003 **Biopsia de médula ósea**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Aplasia: médula vacía, reemplazada por grasa.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 22
Tema 8.5

Clase 8.5 en video

09 TEMA 8.5 · APLASIA MEDULAR E HIPOFUNCIÓN MEDULAR ADQUIRIDA VS FÁRMACOS MIELOTÓXICOS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

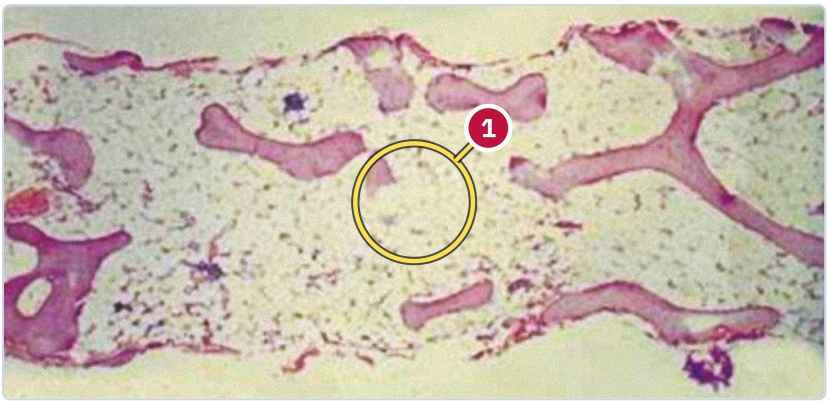


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1. Médula grasa, casi sin células

DIAGNÓSTICO

Aplasia medular

Médula reemplazada por grasa: celularidad bajo 25%.

CONDUCTA INICIAL

Pancitopenia con reticulocitos bajos: biopsia de médula; derivar.

1.08.1.008	Hipofunción medular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.08.4.003	Biopsia de médula ósea	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mielodisplasia: médula llena con displasia.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P5 «Una mujer de 24 años, sin antecedentes de importancia, consulta por disnea de esfuerzos, astenia y palidez de piel y mucosas, asociada a…» → **Aplasia medular**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 22
Tema 8.5

Clase 8.5 en video

10 TEMA 8.5 · APLASIA MEDULAR E HIPOFUNCIÓN MEDULAR ADQUIRIDA VS FÁRMACOS MIELOTÓXICOS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 89

QUÉ TIENES QUE VER

1. Petequias
2. Púrpura

DIAGNÓSTICO

Petequias y púrpura

Puntos rojos que no blanquean, sobre todo en las piernas.

CONDUCTA INICIAL

Plaquetas < 20.000: riesgo de sangrado espontáneo.

1.08.1.012	Púrpuras trombopénicos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.035	Síndrome purpúrico	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Púrpura palpable: vasculitis.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P159 «Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al…» → **Púrpura trombocitopénico inmune**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 22
Tema 8.5

Clase 8.5 en video

11 TEMA 8.6 · ANEMIAS MACROCÍTICAS Y MEGALOBLÁSTICAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

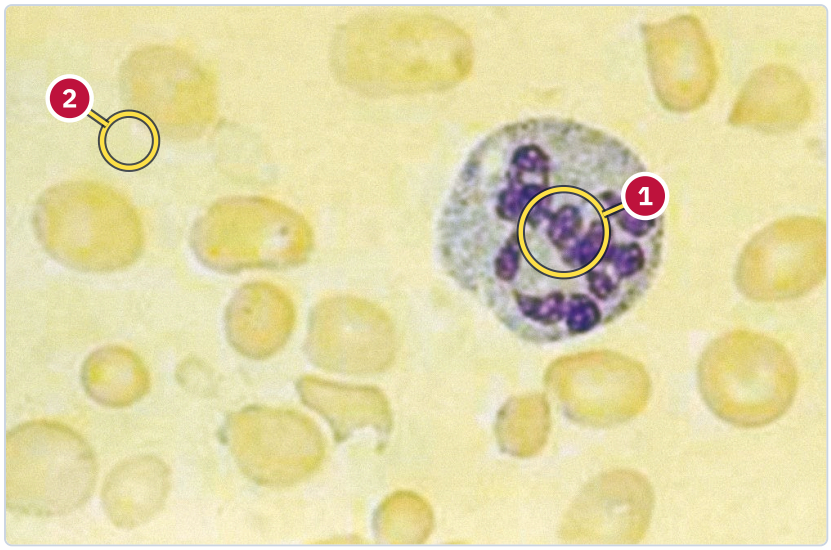


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 29

QUÉ TIENES QUE VER

1. Neutrófilo con más de 5 lóbulos
2. Macroovalocito

DIAGNÓSTICO

Frotis megaloblástico

Macroovalocitos y neutrófilo hipersegmentado.

CONDUCTA INICIAL

Medir B12 y folato; no dar folato solo si falta B12.

1.08.1.004 **Anemia megaloblástica**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Macrocitosis por alcohol: sin hipersegmentación.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P117 «Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también,...» → **Anemia por déficit de vitamina B12**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 29
Tema 8.6

Clase 8.6 en video

12 TEMA 8.6 · ANEMIAS MACROCÍTICAS Y MEGALOBLÁSTICAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 639

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cordones posteriores

DIAGNÓSTICO

Degeneración combinada subaguda

Hiperseñal de los cordones posteriores en la RM cervical.

CONDUCTA INICIAL

Déficit de B12: ataxia, Romberg +; vitamina B12 IM.

1.08.1.004 **Anemia megaloblástica**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

1.10.1.023 **Síndromes sensitivos (polineuropatía, hemihipoestesia, dolor talámico, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Esclerosis múltiple: lesiones en parches.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 29
Tema 8.6

Clase 8.6 en video

13 TEMA 8.6 · ANEMIAS MACROCÍTICAS Y MEGALOBLÁSTICAS

FOTO CLÍNICA

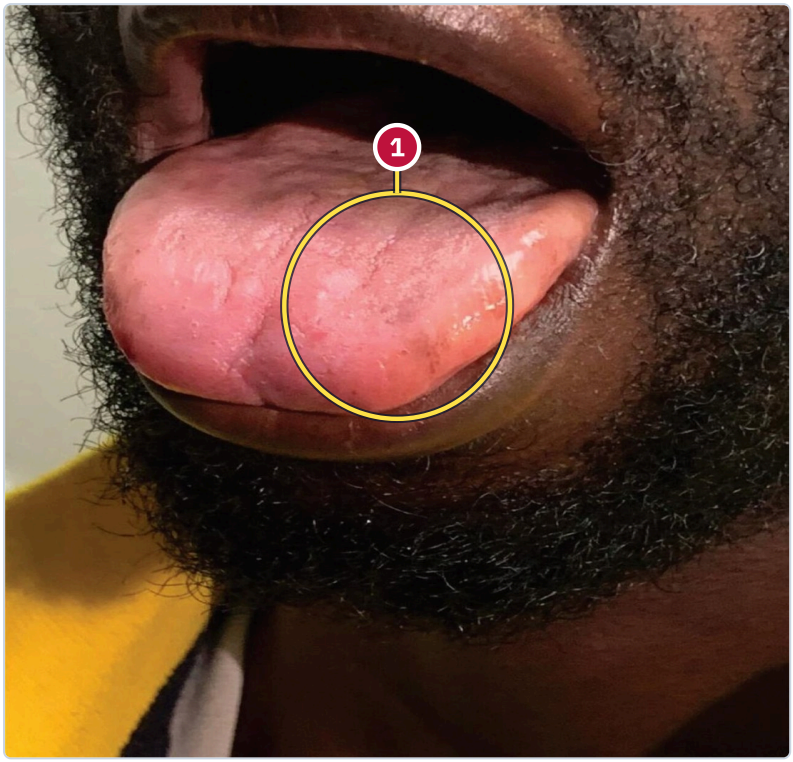


Imagen: Wikimedia Commons «Tongue of person with pernicious anemia two weeks following vitamin B12 supplementation.jpg», CC BY 4.0, Emmanuel Jojo Aryee and Helen Agyei-Yeboah

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lengua roja y lisa

DIAGNÓSTICO

Glositis de Hunter

Lengua lisa, depapilada y roja.

CONDUCTA INICIAL

Anemia perniciosa: anticuerpos antifactor intrínseco; B12 IM de por vida.

1.08.1.004 **Anemia megaloblástica**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Glositis ferropénica: pálida.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 29** Tema 8.6

Clase 8.6 en video

14 TEMA 8.7 · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI

ESQUEMA

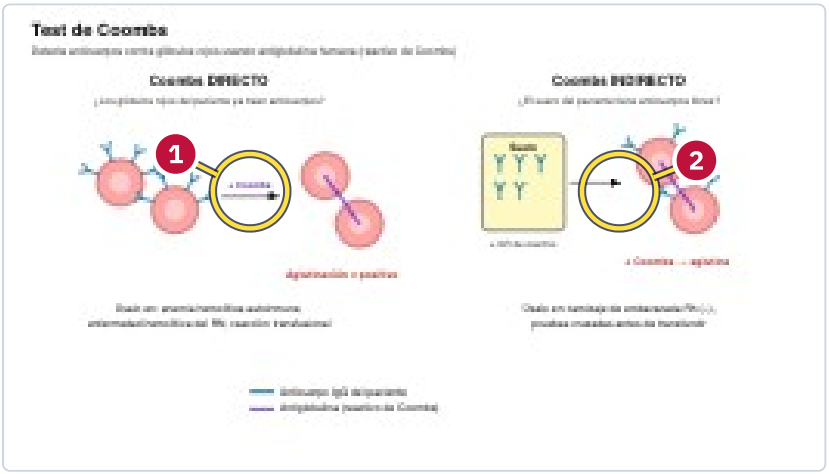


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Coombs directo
2. Coombs indirecto

DIAGNÓSTICO

Prueba de Coombs directa e indirecta

El reactivo de Coombs aglutina los glóbulos cubiertos de anticuerpos.

CONDUCTA INICIAL

AHAI: Coombs directo positivo; prednisona.

1.08.4.010 **Pruebas de hemólisis**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Coombs indirecto: tamizaje de la embarazada y pruebas cruzadas.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P52** «Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen…» → **Prueba de Coombs**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 33** Tema 8.7

Clase 8.7 en video

15 TEMA 8.7 · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons, dominio público

QUÉ TIENES QUE VER

1. Esclera amarilla

DIAGNÓSTICO

Ictericia flavínica

Pálido y amarillo a la vez: bilirrubina indirecta.

CONDUCTA INICIAL

Hemólisis: LDH alta, haptoglobina baja, reticulocitos altos.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ictericia obstructiva: coluria y acolia.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P87 «Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen…» → **Hemograma con reticulocitos**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 34
Tema 8.7

Clase 8.7 en video

16 TEMA 8.7 · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI

FOTO CLÍNICA

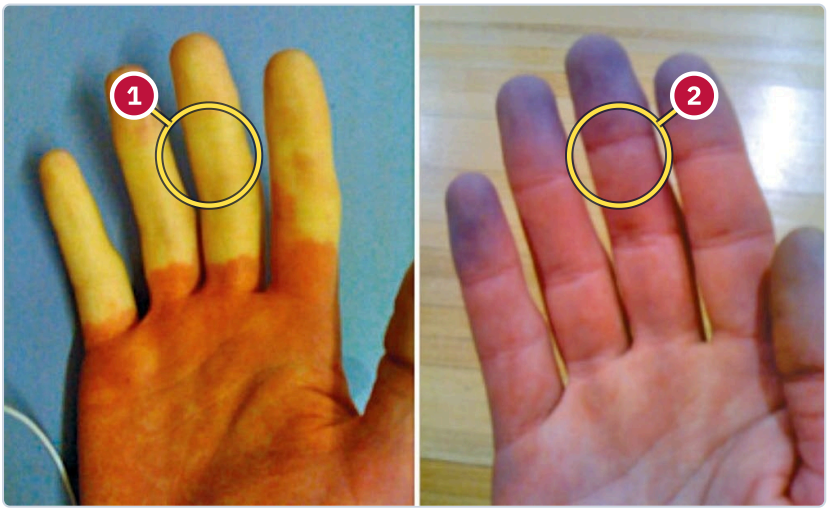


Imagen: Manual AMIR Reumatología, p. 98

QUÉ TIENES QUE VER

1. Palidez
2. Cianosis

DIAGNÓSTICO

Fenómeno de Raynaud

Dedos pálidos y luego cianóticos con el frío.

CONDUCTA INICIAL

Crioaglutininas (IgM): evitar el frío; corticoides no sirven.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Raynaud primario: mujer joven, sin hemólisis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 34
Tema 8.7

Clase 8.7 en video

17 TEMA 8.7 · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE (AHAI

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

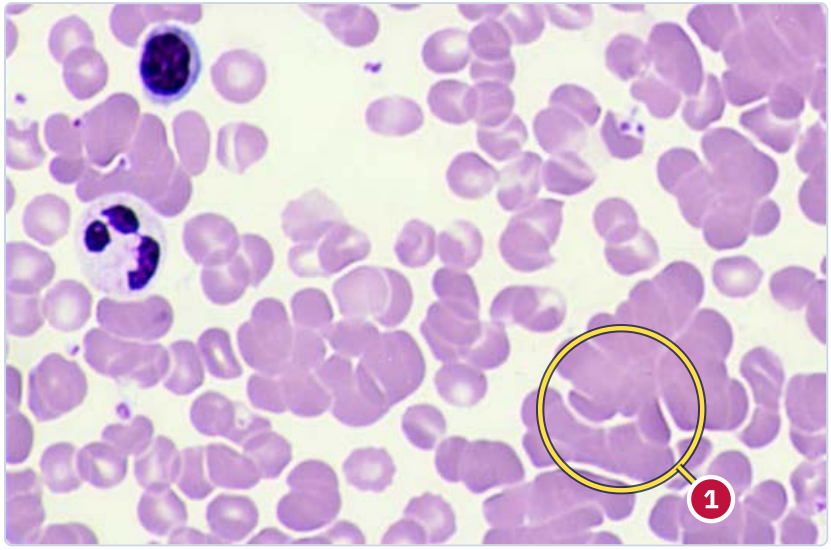


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Grumos de glóbulos rojos

DIAGNÓSTICO

Autoaglutinación por crioaglutininas

Glóbulos rojos agrupados en grumos.

CONDUCTA INICIAL

Enfermedad por crioaglutininas: buscar Mycoplasma o linfoma.

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rouleaux: pilas de monedas, no grumos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 33** Tema 8.7

Clase 8.7 en video

18 TEMA 8.8 · ESFEROCITOSIS HEREDITARIA, DÉFICIT DE G6PD (FAVISMO) Y HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

ESQUEMA

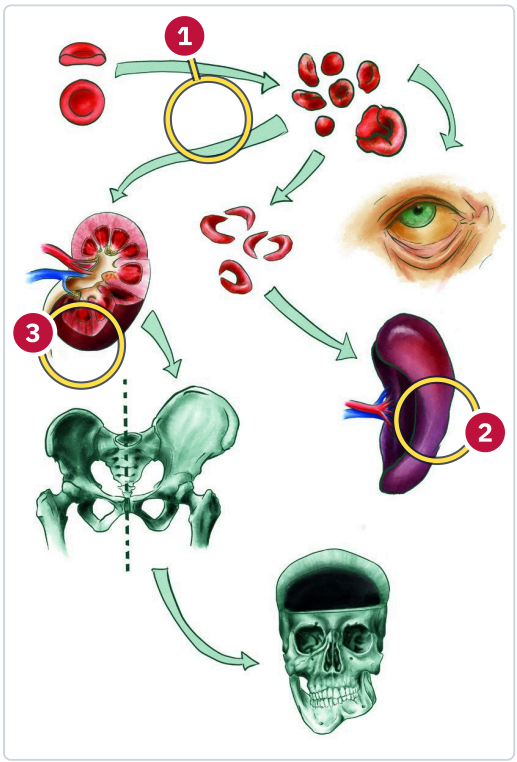


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 30

QUÉ TIENES QUE VER

1. Esferocitos
2. Bazo
3. Cálculos pigmentarios

DIAGNÓSTICO

Patogenia de la esferocitosis

Pierde membrana, se vuelve esfera y el bazo la destruye.

CONDUCTA INICIAL

Esplenectomía en las formas graves; vacunas antes.

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

AHAI: también esferocitos, con Coombs positivo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 39** Tema 8.8

Clase 8.8 en video

19 TEMA 8.8 · ESFEROCITOSIS HEREDITARIA, DÉFICIT DE G6PD (FAVISMO) Y HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

ECOGRAFÍA

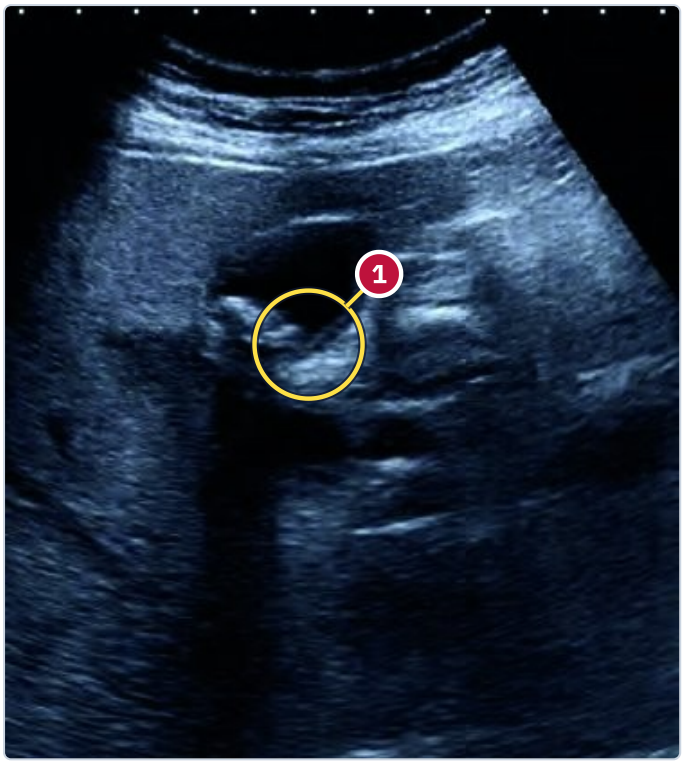


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cálculo

DIAGNÓSTICO

Colelitiasis pigmentaria

Cálculo con sombra acústica en la vesícula.

CONDUCTA INICIAL

Hemólisis crónica: cálculos desde joven.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo vesicular: sin sombra y no se mueve.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 39 Tema 8.8

Clase 8.8 en video

20 TEMA 8.8 · ESFEROCITOSIS HEREDITARIA, DÉFICIT DE G6PD (FAVISMO) Y HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

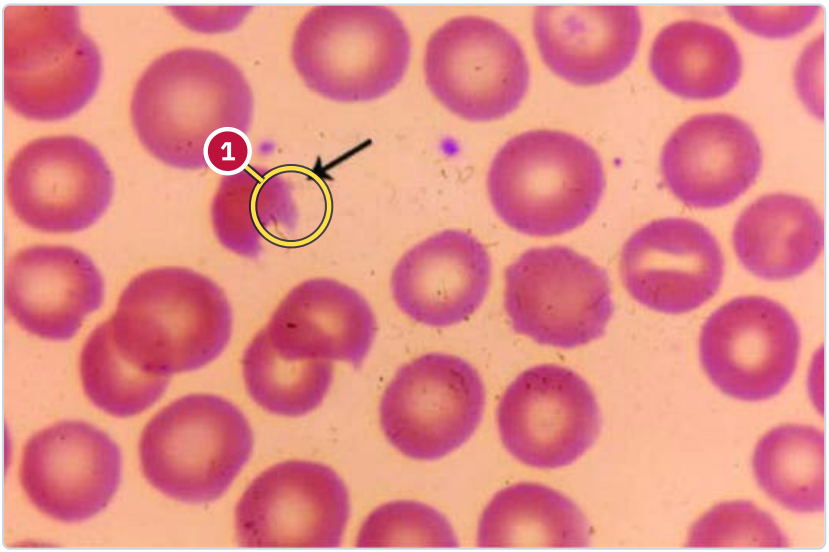


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Célula mordida

DIAGNÓSTICO

Déficit de G6PD: célula mordida

Glóbulo con una mordida (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Evitar habas, sulfas y primaquina; hemólisis tras oxidantes.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esquistocito: fragmento en casco.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 40 Tema 8.8

Clase 8.8 en video

21 TEMA 8.8 · ESFEROCITOSIS HEREDITARIA, DÉFICIT DE G6PD (FAVISMO) Y HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

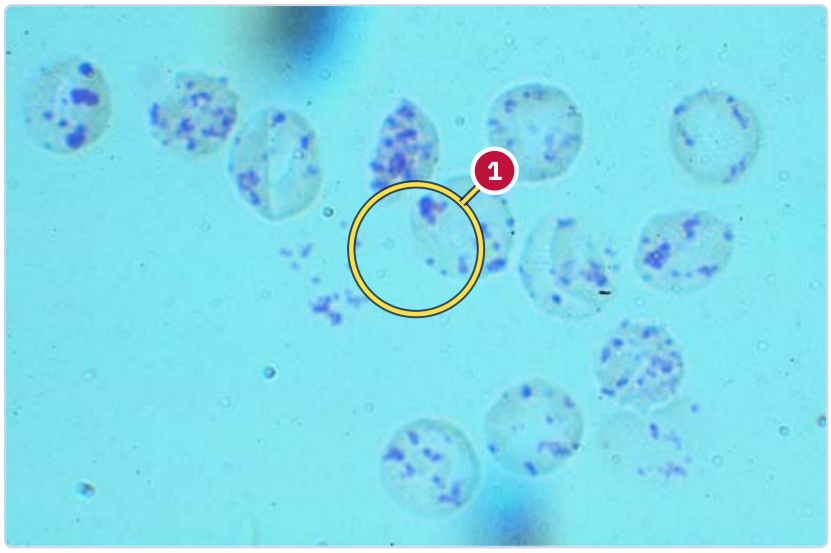


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st ed., p. 470

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuerpos de Heinz

DIAGNÓSTICO

Cuerpos de Heinz

Puntos azules de hemoglobina precipitada dentro de los glóbulos.

CONDUCTA INICIAL

G6PD: los cuerpos de Heinz aparecen con tinción supravital.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Punteado basófilo: plomo o talasemia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 39 Tema 8.8

Clase 8.8 en video

22 TEMA 8.9 · TALASEMIAS (RASGO BETA VS MAYOR) Y DREPANOCITOSIS / ANEMIA FALCIFORME (HBS)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

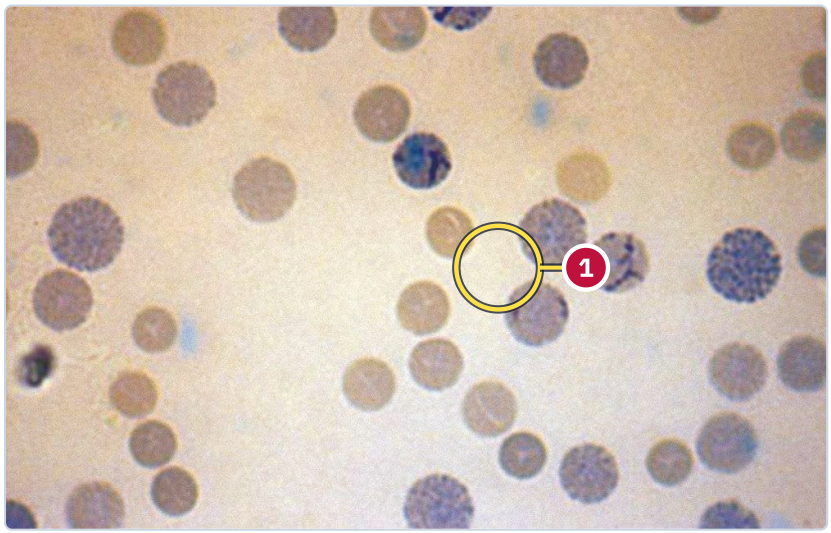


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 37

QUÉ TIENES QUE VER

1 Glóbulo con inclusiones de Hb H

DIAGNÓSTICO

Cuerpos de hemoglobina H

Glóbulos en pelota de golf: α-talasemia.

CONDUCTA INICIAL

Microcitosis con ferritina normal: electroforesis de hemoglobina.

1.08.1.003 Anemia hemolítica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ferropenia: ferritina baja.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 43 Tema 8.9

Clase 8.9 en video

23 TEMA 8.9 · TALASEMIAS (RASGO BETA VS MAYOR) Y DREPANOCITOSIS / ANEMIA FALCIFORME (HBS)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dianocito

DIAGNÓSTICO

Dianocitos

Glóbulos en diana: centro teñido con anillo pálido.

CONDUCTA INICIAL

Talasemia: RDW normal y microcitosis homogénea.

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hepatopatía: también dianocitos, sin microcitosis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 43 Tema 8.9

Clase 8.9 en video

24 TEMA 8.9 · TALASEMIAS (RASGO BETA VS MAYOR) Y DREPANOCITOSIS / ANEMIA FALCIFORME (HBS)

IMAGEN RADIOLÓGICA

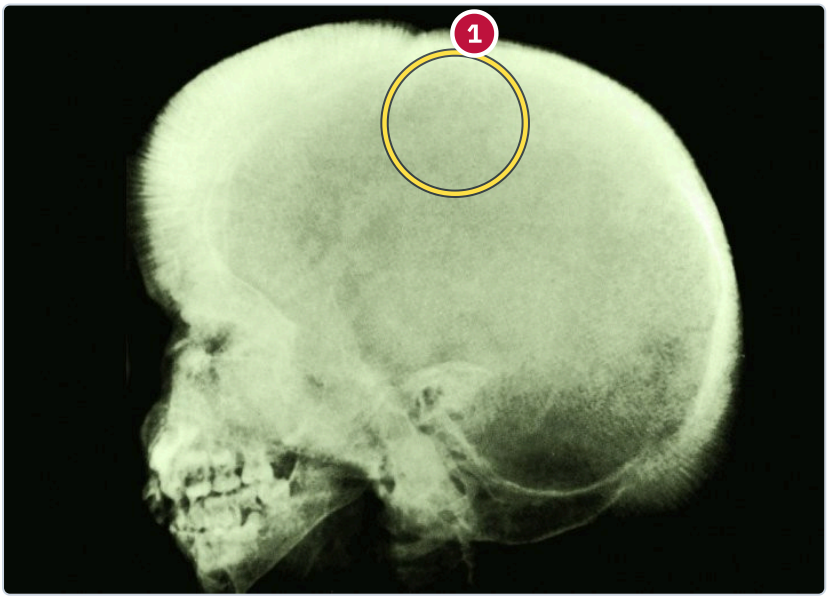


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 32

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bóveda en cepillo

DIAGNÓSTICO

Cráneo en cepillo

Expansión de la médula de la bóveda craneal.

CONDUCTA INICIAL

Talasemia mayor: transfusiones y quelación del hierro.

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cráneo de mieloma: lesiones en sacabocado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 43 Tema 8.9

Clase 8.9 en video

25 TEMA 8.9 · TALASEMIAS (RASGO BETA VS MAYOR) Y DREPANOCITOSIS / ANEMIA FALCIFORME (HBS)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuerpo de Howell-Jolly

DIAGNÓSTICO

Cuerpos de Howell-Jolly

Pequeño punto morado dentro del glóbulo: asplenia.

CONDUCTA INICIAL

Drepanocitosis con autoesplenectomía: vacunas y profilaxis.

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Plaqueta encima del glóbulo: tiene halo.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 43 Tema 8.9

Clase 8.9 en video

26 TEMA 8.10 · MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (MAT)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

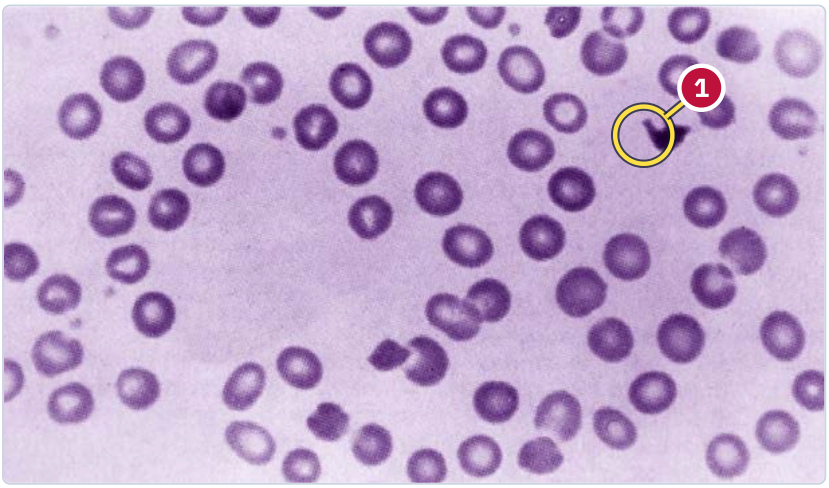


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Esquistocito

DIAGNÓSTICO

Esquistocitos

Glóbulos fragmentados en casco.

CONDUCTA INICIAL

PTT: plasmaféresis urgente; no transfundir plaquetas.

1.08.1.012 Púrpuras trombopénicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esferocitos: redondos y enteros.

PREGUNTA REAL — **Julio 2025 · P131** «Paciente hospitalizado en anticoagulación con heparina no fraccionada. Exámenes: TP 14s (normal), TTPA 120s (normal 25-35s), plaquetas 45.000/mm³…» → **Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)**…

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA p. 47 Tema 8.10

Clase 8.10 en video

27 TEMA 8.10 · MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (MAT)

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st ed., p. 468

QUÉ TIENES QUE VER

1. Fragmentos

DIAGNÓSTICO

Esquistocitos abundantes

Muchos fragmentos: microangiopatía trombótica.

CONDUCTA INICIAL

SHU en niño tras diarrea: soporte y diálisis si falla el riñón.

`2.01.1.067` **Síndrome hemolítico urémico**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.08.1.012` **Púrpuras trombopénicos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

CID: con TP y TTPK prolongados.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P17 «Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar...» → **Síndrome hemolítico urémico**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 47
Tema 8.10

Clase 8.10 en video

28 TEMA 8.11 · FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA Y EVALUACIÓN DE LABORATORIO

ESQUEMA

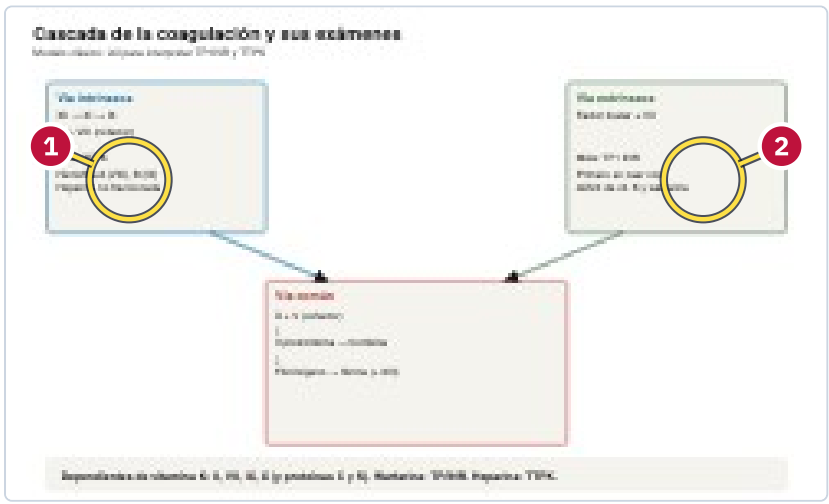


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Vía intrínseca: TTPK
2. Vía extrínseca: TP

DIAGNÓSTICO

Cascada de la coagulación y sus exámenes

TTPK mide la vía intrínseca; TP/INR, la extrínseca.

CONDUCTA INICIAL

TTPK largo aislado: hemofilia o heparina; TP largo: warfarina o déficit de vitamina K.

`1.08.4.005` **Estudio de coagulopatías**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Tiempo de sangría: plaquetas, no coagulación.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P78 «Una niña de 15 años presenta hipermenorrea y menometrorragia de larga data. Se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9g/dl,...» → **Estudio de hemostasia**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 55
Tema 8.11

Clase 8.11 en video

29 TEMA 8.12 · TROMBOCITOPENIAS Y PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI) DEL ADULTO Y NIÑO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

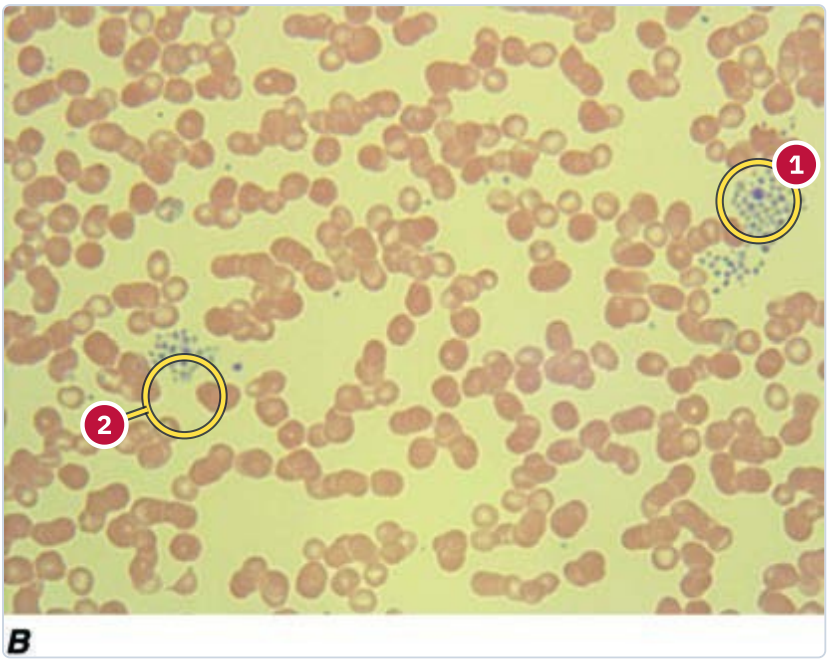


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Grumo de plaquetas
2. Grumo de plaquetas

DIAGNÓSTICO

Pseudotrombocitopenia por EDTA

Plaquetas agrupadas en grumos.

CONDUCTA INICIAL

Plaquetas bajas sin sangrado: repetir en tubo con citrato.

1.08.1.012 Púrpuras trombopénicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

PTI: plaquetas sueltas y escasas.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 57** Tema 8.12

Clase 8.12 en video

30 TEMA 8.13 · COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS

PIEZA ANATÓMICA

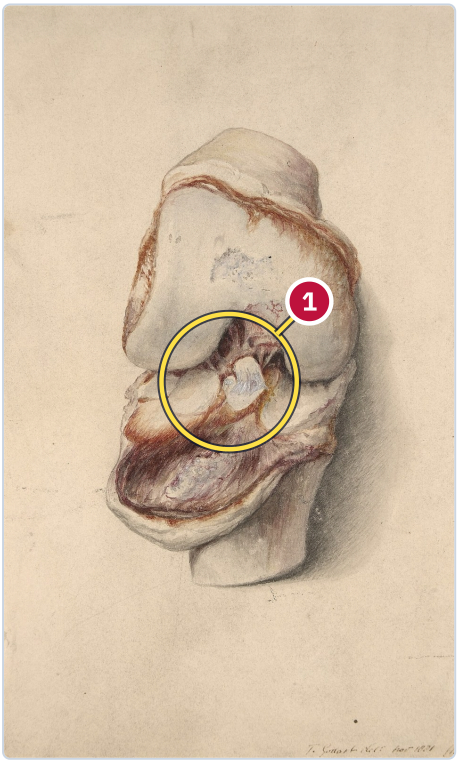


Imagen: Wikimedia Commons «Knee joint of a haemophiliac Wellcome L0062595.jpg», CC BY 4.0, Godart, Thomas

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cartílago destruido

DIAGNÓSTICO

Artropatía hemofílica

Rodilla destruida por hemartrosis repetidas.

CONDUCTA INICIAL

Hemofilia: profilaxis con factor VIII o IX para evitarla.

1.08.1.006 Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.1.036 Trastornos coagulación — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artrosis: sin antecedente de hemartrosis.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2019 · P159** «Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se…» → **Hemofilia**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 62** Tema 8.13

Clase 8.13 en video

31 TEMA 8.13 · COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3858

QUÉ TIENES QUE VER

1 Psoas aumentado

DIAGNÓSTICO

Hematoma del psoas en la TAC

Aumento de volumen del psoas derecho.

CONDUCTA INICIAL

Hemofilia: reponer el factor de inmediato.

1.08.1.006 **Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.2.003 **Coagulopatía congénita sangrante**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Absceso del psoas: fiebre y gas.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P35 «Niño con equimosis frecuentes, TTPA prolongado al triple, hermano fallecido por hemorragia intracraneal. ¿Cuál es el examen para el diagnóstico?» → **Factores de coagulación VIII y IX**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 63
Tema 8.13

Clase 8.13 en video

32 TEMA 8.15 · COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 38

QUÉ TIENES QUE VER

1 Púrpura confluente

DIAGNÓSTICO

Púrpura en una sepsis (CID)

Equimosis extensas y confluentes.

CONDUCTA INICIAL

CID: tratar la causa; plasma, crioprecipitado y plaquetas si sangra.

1.08.2.001 **Coagulación intravascular diseminada**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

PTI: petequias sin shock.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P54 «Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl,…» → **Plasma fresco congelado**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 71
Tema 8.15

Clase 8.15 en video

33 TEMA 8.16 · LEUCEMIAS AGUDAS

FOTO CLÍNICA

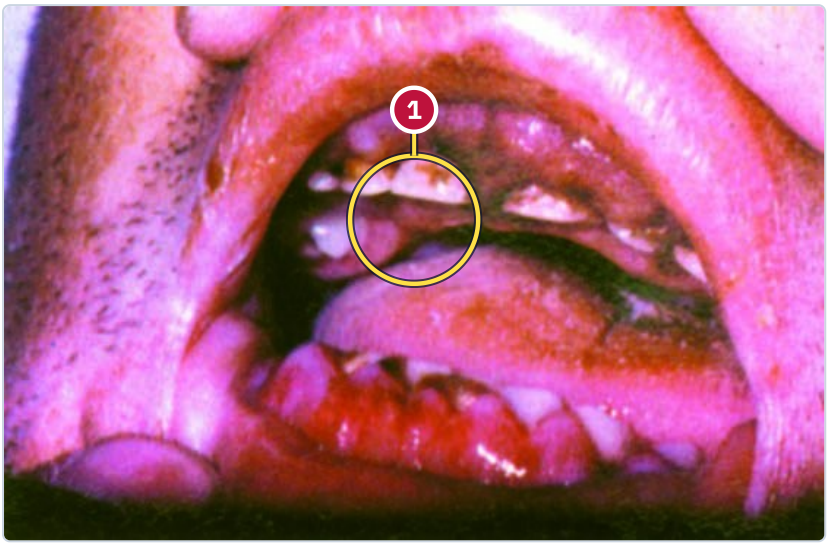


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 63

QUÉ TIENES QUE VER

1 Encías infiltradas

DIAGNÓSTICO

Infiltración gingival

Encías hiperplásicas: LMA mielomonocítica o monocítica.

CONDUCTA INICIAL

Hemograma y frotis; derivar urgente a hematología.

1.08.1.009 **Leucemias agudas**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hiperplasia por fenitoína: sin citopenias.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P118 «Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado gene- ral, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia…» → **Leucemia aguda**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 79
Tema 8.16

Clase 8.16 en video

34 TEMA 8.16 · LEUCEMIAS AGUDAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

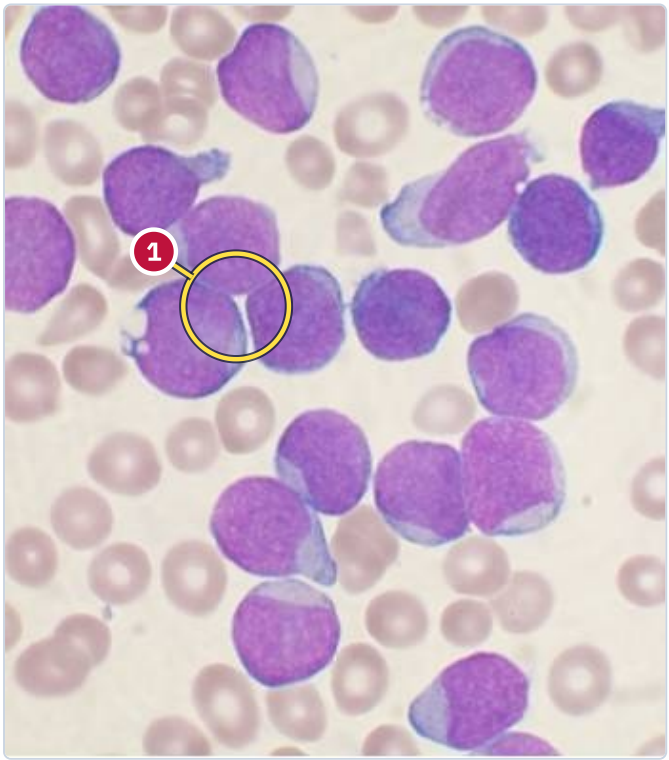


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Linfoblasto

DIAGNÓSTICO

Linfoblastos

Células pequeñas con poco citoplasma y sin gránulos.

CONDUCTA INICIAL

Blastos > 20% en médula: leucemia aguda; mielograma.

1.08.1.009 **Leucemias agudas**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.1.032 **Leucemias**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.4.009 **Mielograma**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mieloblasto: grande, con gránulos y bastones de Auer.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P27 «Un niño de 8 años presenta dolores óseos generalizados, asociada a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa…» → **Mielograma**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 79
Tema 8.16

Clase 8.16 en video

35 TEMA 8.16 · LEUCEMIAS AGUDAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

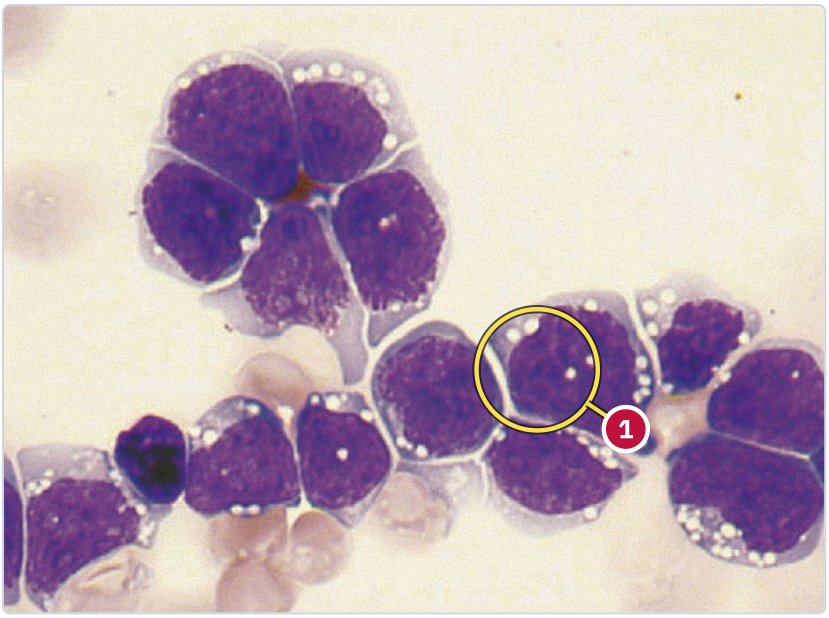


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1. Citoplasma vacuolado

DIAGNÓSTICO

Blastos tipo Burkitt

Blastos grandes de citoplasma azul con vacuolas.

CONDUCTA INICIAL

Riesgo alto de lisis tumoral: hidratación y alopurinol o rasburicasa.

1.08.1.009 Leucemias agudas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Linfocito reactivo: citoplasma amplio sin vacuolas.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 79** Tema 8.16

Clase 8.16 en video

36 TEMA 8.17 · LEUCEMIAS CRÓNICAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

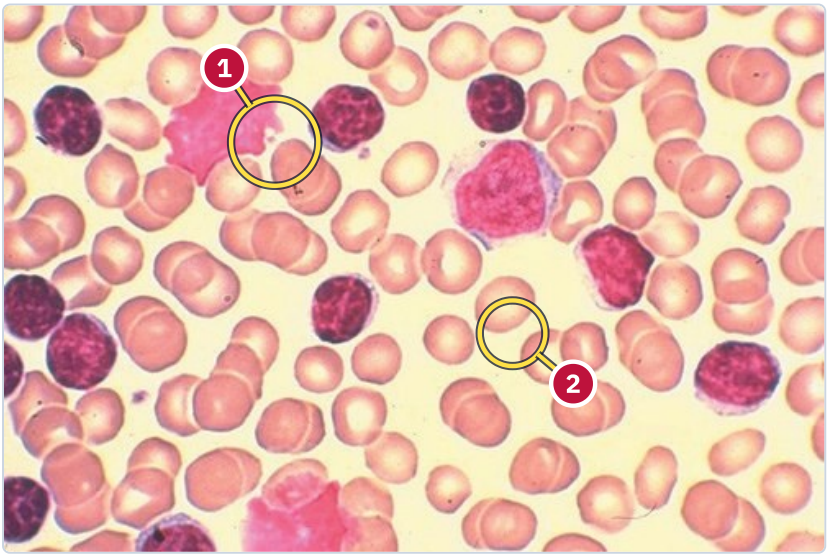


Imagen: Goljan, Rapid Review Pathology, Link 13-19

QUÉ TIENES QUE VER

1. Sombra de Gümprecht
2. Linfocito pequeño maduro

DIAGNÓSTICO

Sombras de Gümprecht

Núcleos de linfocitos rotos en el frotis de una LLC.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor con linfocitosis: citometría de flujo.

1.08.1.010 Leucemias crónicas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Linfocitosis reactiva: linfocitos activados.

PREGUNTA REAL — **Julio 2015 · P12** «Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra…» → **Leucemia linfática crónica**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 84** Tema 8.17

Clase 8.17 en video

37 TEMA 8.17 · LEUCEMIAS CRÓNICAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

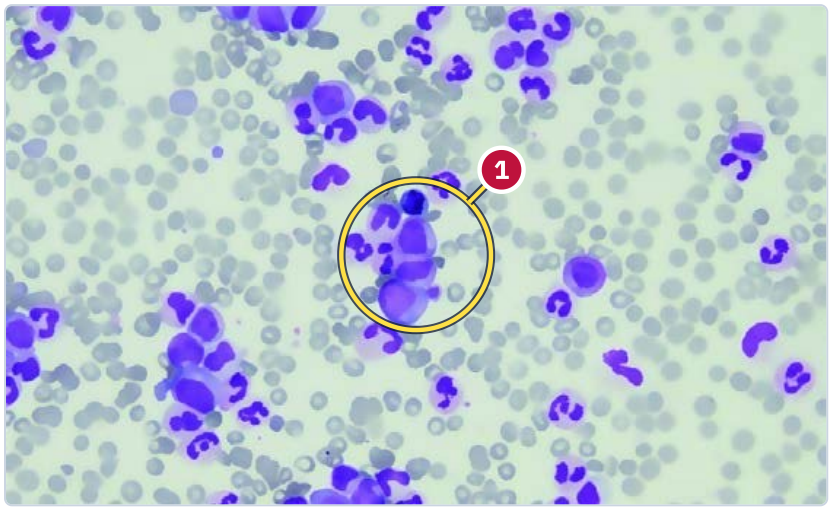


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 53

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mielocitos y baciliformes

DIAGNÓSTICO

Leucemia mieloide crónica

Leucocitosis con todas las formas inmaduras de la serie.

CONDUCTA INICIAL

BCR-ABL; imatinib.

1.08.1.010 Leucemias crónicas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Reacción leucemoide: con infección y sin BCR-ABL.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P79 «Un paciente de 35 años presenta un cuadro de 5 días de tos con expectoración mucopurulenta, asociada a malestar general, fiebre y dolor torácico…» → **Reacción leucemoide**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 85
Tema 8.17

Clase 8.17 en video

38 TEMA 8.17 · LEUCEMIAS CRÓNICAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 107-1

QUÉ TIENES QUE VER

1 Linfocitos pequeños

DIAGNÓSTICO

Leucemia linfática crónica

Muchos linfocitos pequeños y maduros.

CONDUCTA INICIAL

Observación en estadios iniciales.

1.08.1.010 Leucemias crónicas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Linfoma del manto: CD5 + con ciclina D1.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P164 «Una paciente de 83 años se realiza exámenes preoperatorios, por una cirugía de cataratas, entre los que destaca un hemograma con 86.000 glóbulos…» → **Leucemia linfática crónica clásica**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 85
Tema 8.17

Clase 8.17 en video

39 TEMA 8.17 · LEUCEMIAS CRÓNICAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 280

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde del bazo

DIAGNÓSTICO

Esplenomegalia masiva

Bazo marcado hasta la fosa ilíaca.

CONDUCTA INICIAL

LMC o mielofibrosis: hemograma, frotis y BCR-ABL / JAK2.

1.08.1.018	Síndromes mieloproliferativos crónicos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.08.1.010	Leucemias crónicas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hepatomegalia: borde a la derecha.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P9 «Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de aste- nia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos Al…» → **Mielofibrosis primaria**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 96
Tema 8.17

Clase 8.17 en video

40 TEMA 8.18 · LINFOMAS

FOTO CLÍNICA

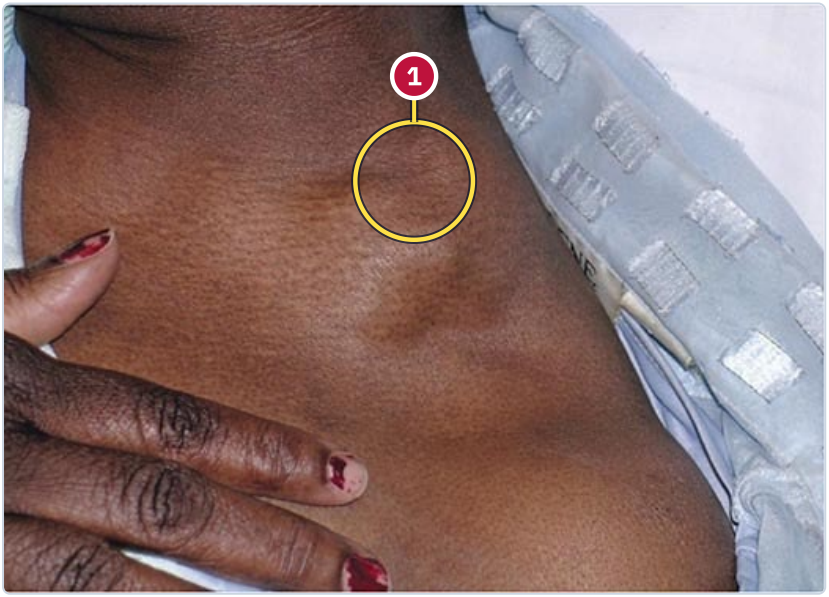


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 193

QUÉ TIENES QUE VER

1 Adenopatía

DIAGNÓSTICO

Adenopatía supraclavicular

Ganglio supraclavicular grande.

CONDUCTA INICIAL

Neoplásica hasta demostrar lo contrario: biopsia ganglionar.

1.08.1.011	Linfomas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.08.5.002	Biopsia ganglionar	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ganglio reactivo: pequeño, blando y doloroso.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P37 «Un hombre de 30 años presenta aumento de volumen en el cuello, desde hace dos meses, que ha progresado desde ese entonces. Además, ha presentado…» → **Biopsia ganglionar**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 88
Tema 8.18

Clase 8.18 en video

41 TEMA 8.18 · LINFOMAS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

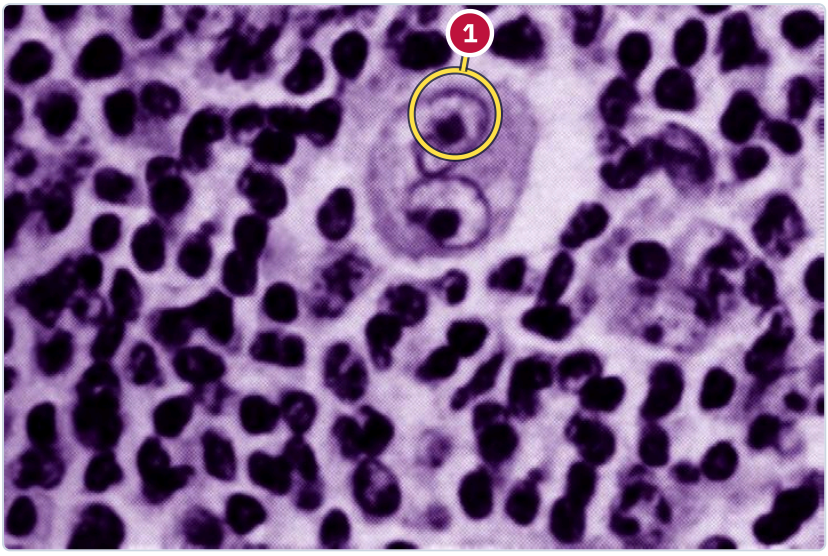


Imagen: Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Núcleos en espejo

DIAGNÓSTICO

Célula de Reed-Sternberg

Célula gigante binucleada en ojos de búho.

CONDUCTA INICIAL

Linfoma de Hodgkin: biopsia, PET-CT y quimioterapia ABVD.

1.08.1.011 Linfomas

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

No Hodgkin: sin Reed-Sternberg.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P106 «Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional…» → **Linfoma**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 75
Tema 8.18

Clase 8.18 en video

42 TEMA 8.18 · LINFOMAS

ENDOSCOPÍA

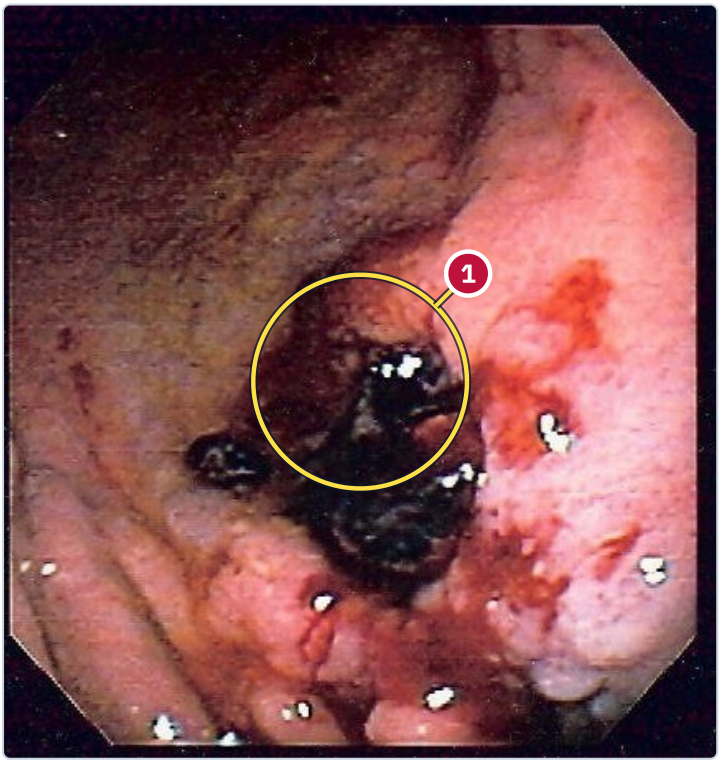


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión ulcerada

DIAGNÓSTICO

Linfoma MALT gástrico

Lesión ulcerada en la mucosa gástrica.

CONDUCTA INICIAL

Erradicar H. pylori: muchos remiten.

1.08.1.011 Linfomas

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer gástrico: biopsia lo separa.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 87
Tema 8.18

Clase 8.18 en video

43 TEMA 8.19 · MIELOMA MÚLTIPLE

ESQUEMA

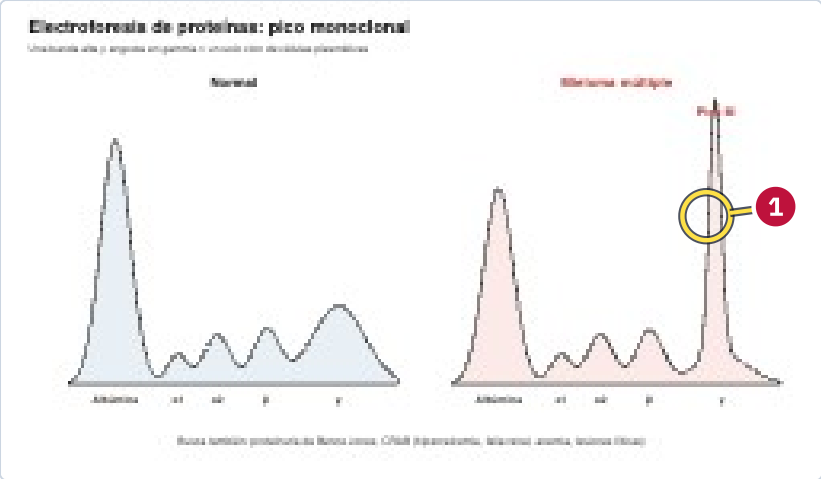


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pico M

DIAGNÓSTICO

Electroforesis: pico monoclonal

Banda alta y angosta en gamma.

CONDUCTA INICIAL

Mieloma: CRAB; buscar Bence Jones.

1.08.4.004	Electroforesis de proteínas — examen/procedimiento
1.08.1.007	Disproteinemias (gammapatías M) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Policlonal: base ancha.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P133** «Un paciente de 78 años, consulta por lumbago de un mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido bien a analgésicos. En su examen…» → **Electroforesis de proteínas en sangre**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 93** Tema 8.19

Clase 8.19 en video

44 TEMA 8.19 · MIELOMA MÚLTIPLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

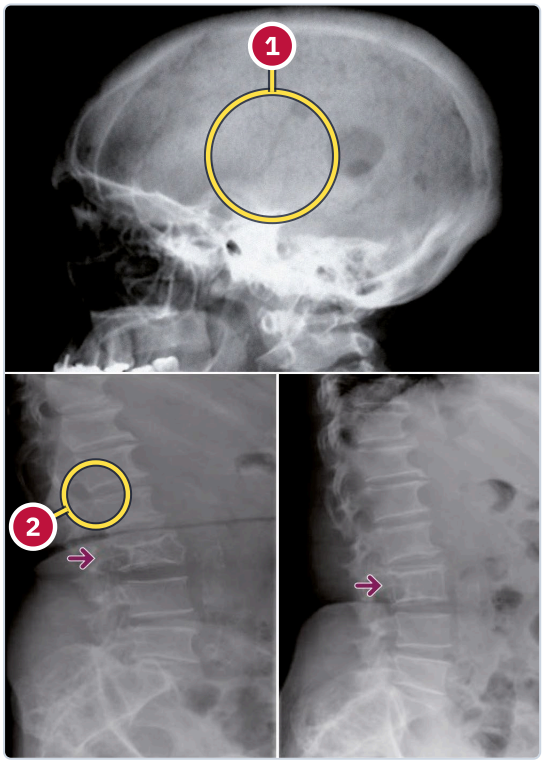


Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 73

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesiones en sacabocado
2. Vértebra aplastada

DIAGNÓSTICO

Lesiones líticas del mieloma

Lesiones en sacabocado en el cráneo y vértebras.

CONDUCTA INICIAL

Electroforesis de proteínas y mielograma.

1.08.1.007	Disproteinemias (gammapatías M) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Metástasis: lesiones de bordes irregulares.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P37** «Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8g/dl, VC;: 85 fl,…» → **Mieloma múltiple**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 93** Tema 8.19

Clase 8.19 en video

45 TEMA 8.19 · MIELOMA MÚLTIPLE

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual AMIR Hematología, p. 74

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rouleaux

DIAGNÓSTICO

Pilas de monedas (rouleaux)

Glóbulos apilados por exceso de proteína.

CONDUCTA INICIAL

VHS muy alta: pensar en mieloma.

1.08.1.007 Disproteinemias (gammapatías M)

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aglutinación: grumos sin orden.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P145 «Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor…» → **Mieloma múltiple**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 93
Tema 8.19

Clase 8.19 en video

46 TEMA 8.20 · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (POLICITEMIA VERA JAK2, TE, MIELOFIBROSIS) Y MIELODISPLASIA

FOTO CLÍNICA

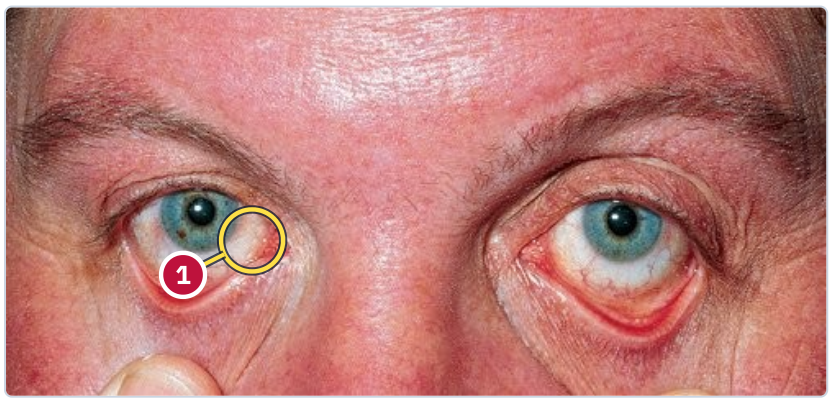


Imagen: Rapid Review Pathology (Goljan), p. 567

QUÉ TIENES QUE VER

1 Conjuntivas rojas

DIAGNÓSTICO

Facies pletórica

Cara y conjuntivas rojas.

CONDUCTA INICIAL

Policitemia vera: JAK2; flebotomías y aspirina.

1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Policitemia secundaria: EPO alta (hipoxemia).

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 98
Tema 8.20

Clase 8.20 en video

47 TEMA 8.20 · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (POLICITEMIA VERA JAK2, TE, MIELOFIBROSIS) Y MIELODISPLASIA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 2012

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pie enrojecido

DIAGNÓSTICO

Eritromelalgia

Dolor quemante con enrojecimiento de los pies.

CONDUCTA INICIAL

Mejora con aspirina.

1.08.1.018 **Síndromes mieloproliferativos crónicos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis: fiebre y unilateral.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 98** Tema 8.20

Clase 8.20 en video

48 TEMA 8.20 · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (POLICITEMIA VERA JAK2, TE, MIELOFIBROSIS) Y MIELODISPLASIA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

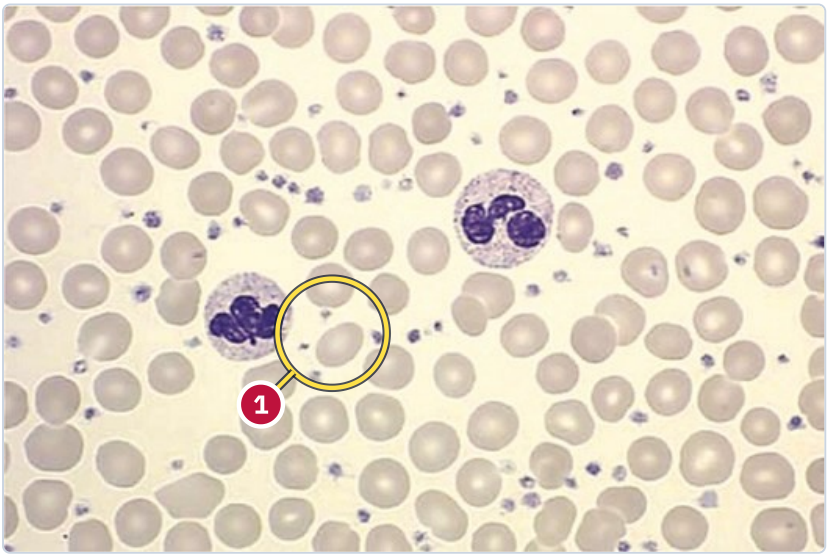


Imagen: Goljan, Rapid Review Pathology, Link 15-14

QUÉ TIENES QUE VER

1 Plaquetas abundantes

DIAGNÓSTICO

Trombocitemia esencial

Muchas plaquetas en el frotis.

CONDUCTA INICIAL

Plaquetas > 450.000 sostenidas: descartar causa reactiva y pedir JAK2.

1.08.1.018 **Síndromes mieloproliferativos crónicos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Trombocitosis reactiva: ferropenia o inflamación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 98** Tema 8.20

Clase 8.20 en video

49 TEMA 8.20 · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (POLICITEMIA VERA JAK2, TE, MIELOFIBROSIS) Y MIELODISPLASIA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dacriocito

DIAGNÓSTICO

Dacriocitos

Glóbulos en lágrima: mielofibrosis.

CONDUCTA INICIAL

Mielofibrosis: aspirado seco, biopsia de médula.

- 1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
- 1.08.1.015 Síndrome leucoeritroblástico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artefacto del extendido: todas las colas hacia el mismo lado.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P9 «Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de aste- nia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos Al…» → **Mielofibrosis primaria**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 99
Tema 8.20

Clase 8.20 en video

50 TEMA 8.20 · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (POLICITEMIA VERA JAK2, TE, MIELOFIBROSIS) Y MIELODISPLASIA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

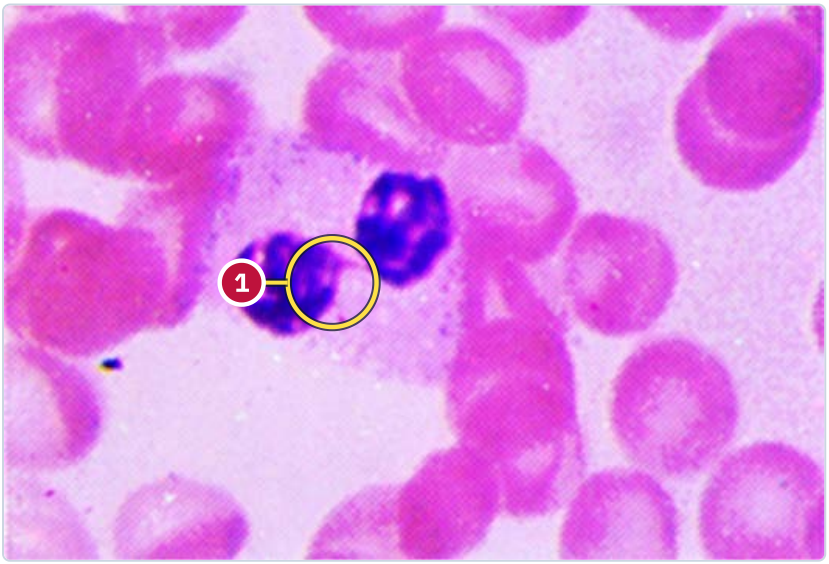


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Neutrófilo bilobulado

DIAGNÓSTICO

Neutrófilo pseudo-Pelger-Huët

Neutrófilo bilobulado e hipogranular: mielodisplasia.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor con citopenias: mielograma.

- 1.08.1.017 Síndromes mielodisplásicos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pelger-Huët hereditario: sin citopenias.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 97
Tema 8.20

Clase 8.20 en video

51 TEMA 8.22 · SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (CAIRO-BISHOP), HIPERCALCEMIA DE NEOPLASIA Y COMPRESIÓN MEDULAR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

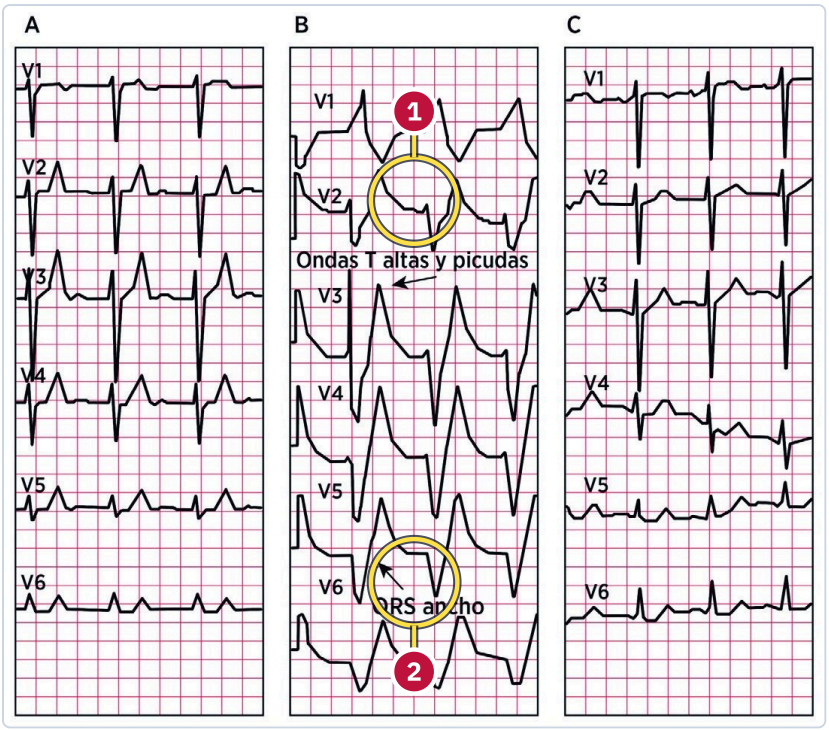


Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 23

QUÉ TIENES QUE VER

1. T picudas
2. QRS ancho

DIAGNÓSTICO

ECG de hiperkalemia

T altas y picudas, luego QRS ancho.

CONDUCTA INICIAL

Lisis tumoral: gluconato de calcio EV primero.

1.08.2.005 **Lisis tumoral aguda**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

T de isquemia hiperaguda: asimétrica.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P20 «Un paciente de 55 años, diagnosticado con un linfoma no Hodgkin con múltiples masas medias ` nicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm,...» → **Síndrome de lisis tumoral**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 109
Tema 8.22

Clase 8.22 en video

52 TEMA 8.22 · SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (CAIRO-BISHOP), HIPERCALCEMIA DE NEOPLASIA Y COMPRESIÓN MEDULAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

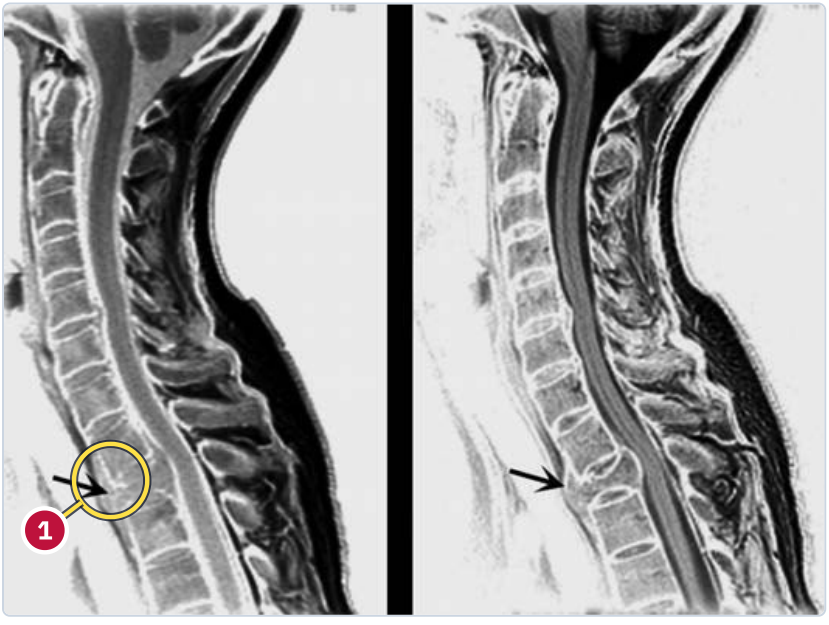


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 3489

QUÉ TIENES QUE VER

1. Compresión medular

DIAGNÓSTICO

Compresión medular por metástasis

Vértebra comprometida que comprime la médula (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Dexametasona de inmediato; RM de columna completa y radioterapia.

1.08.2.007 **Síndrome de compresión medular**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.2.011 **Paraplejia aguda**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Hernia discal: sin destrucción del cuerpo vertebral.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 109
Tema 8.22

Clase 8.22 en video

53 TEMA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS (FACTOR V LEIDEN, PROTROMBINA G20210A) Y SAF

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Necrosis cutánea

DIAGNÓSTICO

Necrosis cutánea por cumarínicos

Piel negra rodeada de eritema.

CONDUCTA INICIAL

Déficit de proteína C: iniciar warfarina con heparina.

1.08.1.019 **Trombofilias**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.3.012 **Tratamiento anticoagulante**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Calcifilaxis: en insuficiencia renal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 113** Tema 8.23

Clase 8.23 en video

54 TEMA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS (FACTOR V LEIDEN, PROTROMBINA G20210A) Y SAF

FOTO CLÍNICA

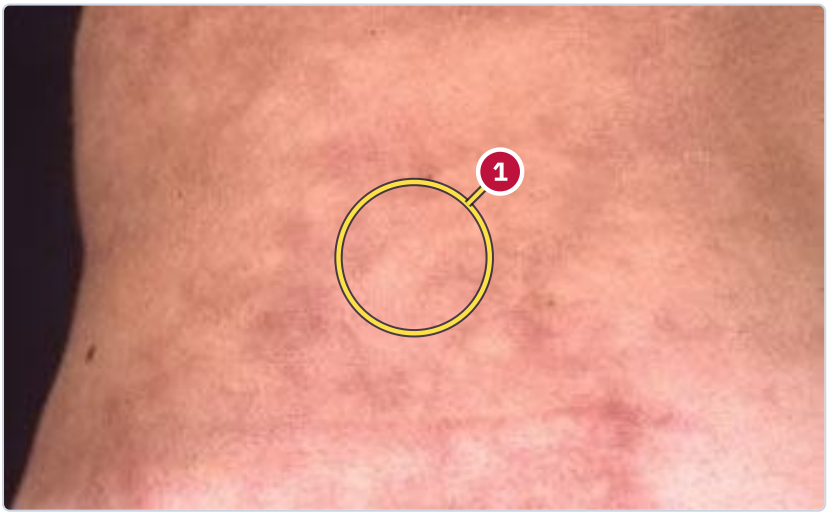


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1652

QUÉ TIENES QUE VER

1 Patrón en red

DIAGNÓSTICO

Livedo reticularis

Red violácea en la piel.

CONDUCTA INICIAL

SAF: anticardiolipina, anti-β2GP1 y anticoagulante lúpico.

1.11.1.021 **Síndrome antifosfolípidos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.1.019 **Trombofilias**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cutis marmorata fisiológico: desaparece al calentar.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P149** «Mujer joven con aborto hace 3 meses y anemia, que presenta una trombosis venosa profunda confirmada por ecografía Doppler. ¿Qué estudio…» → **Anticuerpos antifosfolípidos**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA **p. 113** Tema 8.23

Clase 8.23 en video

55 TEMA 8.24 · MEDICINA TRANSFUSIONAL Y MANEJO DE HEMOCOMPONENTES

IMAGEN RADIOLÓGICA

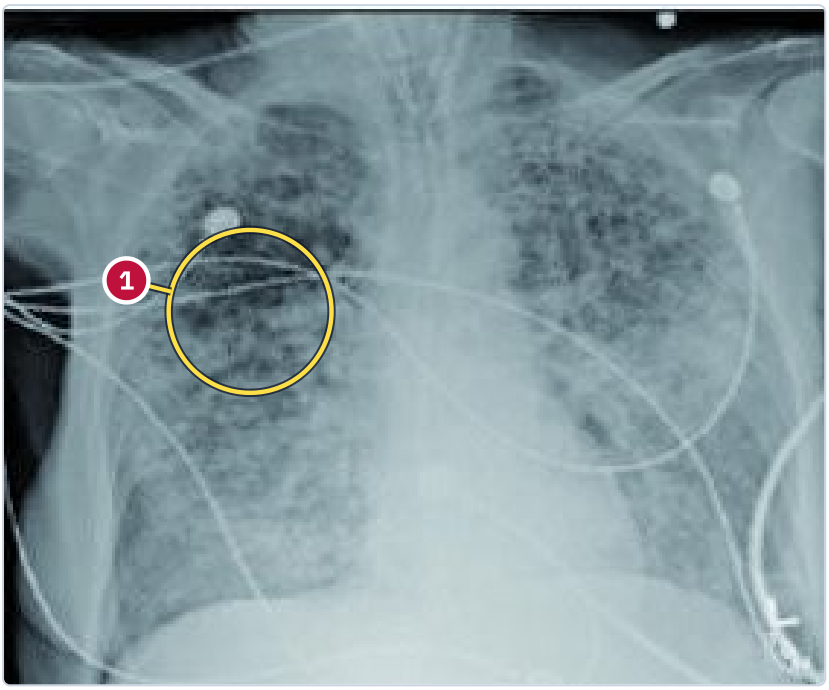


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 35

QUÉ TIENES QUE VER

1 Infiltrados bilaterales

DIAGNÓSTICO

TRALI

Infiltrados bilaterales dentro de 6 horas de la transfusión.

CONDUCTA INICIAL

Detener la transfusión y soporte ventilatorio; no dar diuréticos.

1.08.3.011 **Transfusión y sus complicaciones**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

TACO: con sobrecarga de volumen e hipertensión.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 116
Tema 8.24

Clase 8.24 en video

56 TEMA 8.24 · MEDICINA TRANSFUSIONAL Y MANEJO DE HEMOCOMPONENTES

IMAGEN RADIOLÓGICA

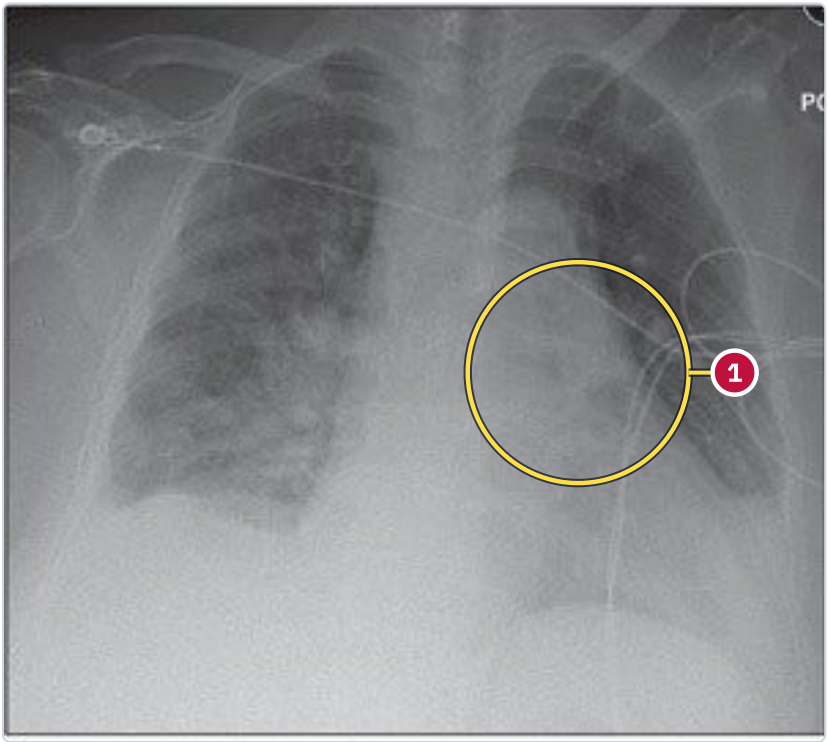


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 303

QUÉ TIENES QUE VER

1 Edema bilateral

DIAGNÓSTICO

TACO

Edema pulmonar cardiogénico por exceso de volumen.

CONDUCTA INICIAL

Detener la transfusión y dar furosemida.

1.08.3.011 **Transfusión y sus complicaciones**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

TRALI: sin sobrecarga, no responde a diuréticos.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P14 «Una paciente de 68 años sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis inestable y hemorragia masiva, ingresando para su…» → **Administrar las dos unidades O-Rh negativo y, en caso…**

TOMO HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA
p. 116
Tema 8.24

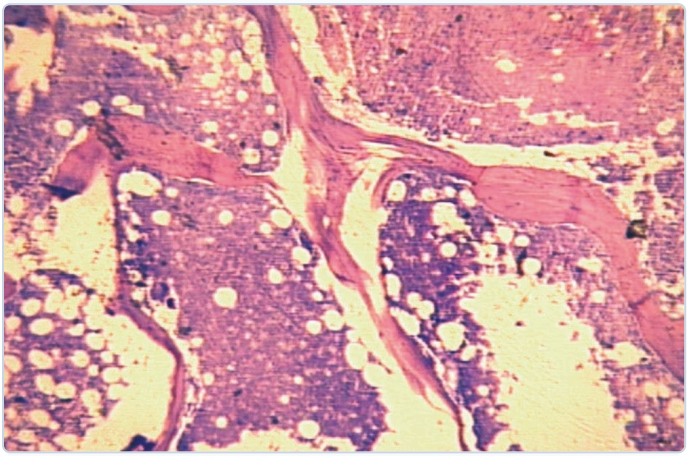
Clase 8.24 en video

Parecidas pero distintas

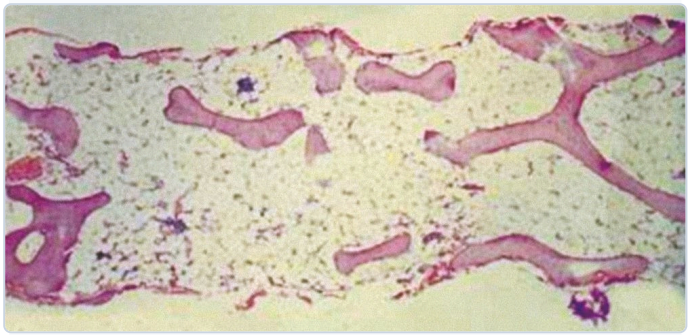
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Médula normal vs aplasia



VS



A **Médula ósea normal**

- Células y grasa

Ficha n.° 08 · p. 7

B **Aplasia medular**

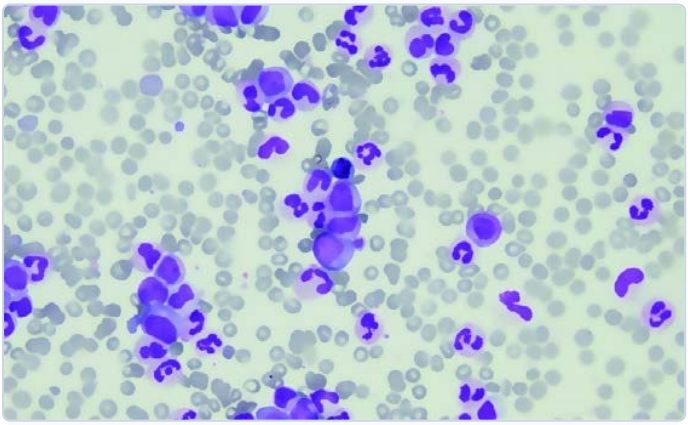
- Casi solo grasa

Ficha n.° 09 · p. 8

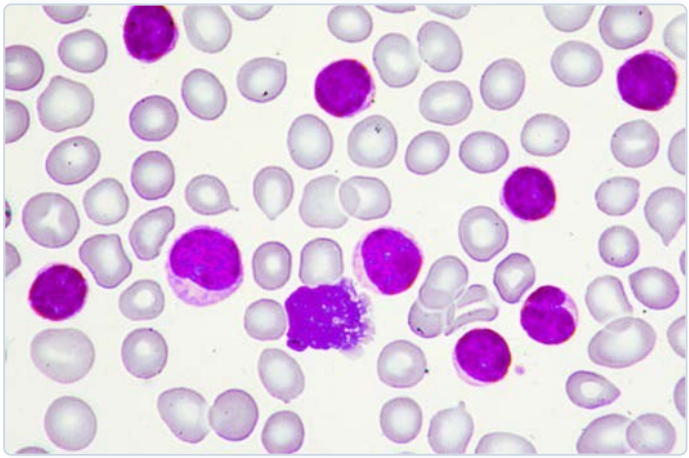
LA DIFERENCIA Celularidad bajo 25%: aplasia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

LMC vs LLC



VS



A **Leucemia mieloide crónica**

- Formas mieloides inmaduras

Ficha n.° 37 · p. 22

B **Leucemia linfática crónica**

- Linfocitos maduros pequeños

Ficha n.° 38 · p. 22

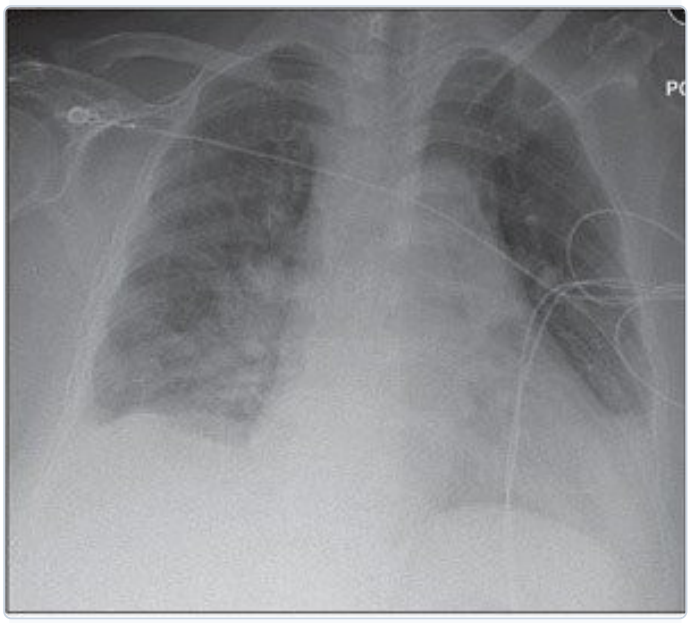
LA DIFERENCIA BCR-ABL en la LMC; citometría en la LLC.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

TRALI vs TACO



VS



A **TRALI**

- Sin sobrecarga

Ficha n.° 55 · p. 31

B **TACO**

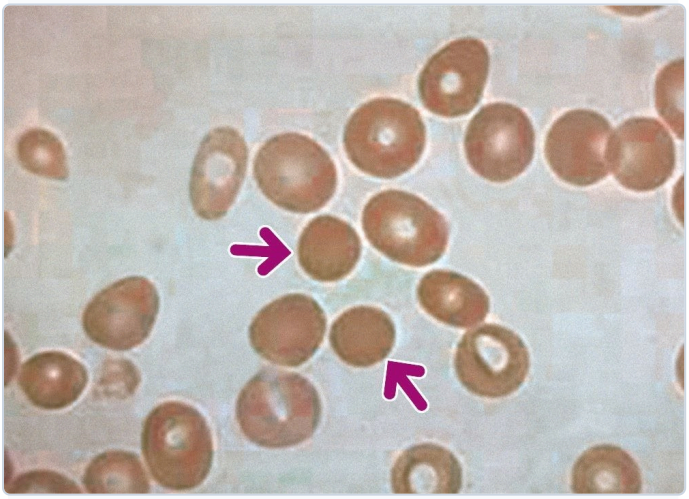
- Con sobrecarga

Ficha n.° 56 · p. 31

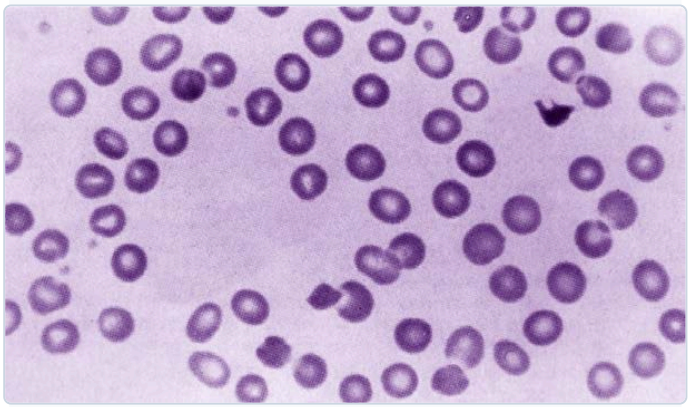
LA DIFERENCIA Solo el TACO responde a diuréticos.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Esferocitos vs esquistocitos



VS



A **Esferocitos**

- Redondos, sin palidez

Ficha n.° 03 · p. 5

B **Esquistocitos**

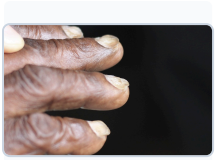
- Fragmentos en casco

Ficha n.° 26 · p. 16

LA DIFERENCIA Esquistocitos: microangiopatía.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

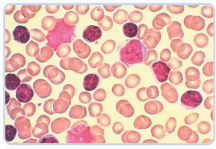


COILONIQUIA

Uñas en cuchara.

Se ve en: Ferropenia.

Tomo p. 12 · Atlas: ficha n.° 04, p. 5

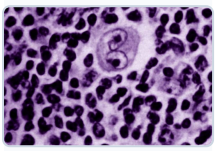


SOMBRAS DE GÜMPRECHT

Núcleos rotos en el frotis.

Se ve en: Leucemia linfática crónica.

Tomo p. 84 · Atlas: ficha n.° 36, p. 21

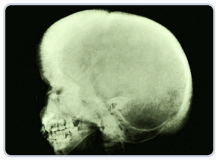


REED-STERNBERG

Célula binucleada en ojos de búho.

Se ve en: Linfoma de Hodgkin.

Tomo p. 75 · Atlas: ficha n.° 41, p. 24



CRÁNEO EN CEPILLO

Expansión medular de la bóveda.

Se ve en: Talasemia mayor.

Tomo p. 43 · Atlas: ficha n.° 24, p. 15

Índice por tipo de imagen

15	26	4	7	1	1
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA

1	1
ENDOSCOPÍA	PIEZA ANATÓMICA

Foto clínica · 15

04 Coiloniquia (8.3) 5
05 Queilitis angular (8.3) 6
06 Glositis atrófica (8.3) 6
10 Petequias y púrpura (8.5) 8
13 Glositis de Hunter (8.6) 10
15 Ictericia flavínica (8.7) 11
16 Fenómeno de Raynaud (8.7) 11
32 Púrpura en una sepsis (CID) (8.15) 19
33 Infiltración gingival (8.16) 20
39 Esplenomegalia masiva (8.17) 23
40 Adenopatía supraclavicular (8.18) 23
46 Facies pletórica (8.20) 26
47 Eritromelalgia (8.20) 27
53 Necrosis cutánea por cumarínicos (8.23) 30
54 Livedo reticularis (8.23) 30

Histología / citología · 26

01 Frotis de sangre periférica normal (8.1) 4
02 Microcitosis e hipocromía (8.1) 4
03 Esferocitos (8.1) 5
07 Frotis de anemia ferropénica (8.3) 7
08 Médula ósea normal (8.5) 7
09 Aplasia medular (8.5) 8
11 Frotis megaloblástico (8.6) 9
17 Autoaglutinación por crioaglutininas (8.7) 12
20 Déficit de G6PD: célula mordida (8.8) 13
21 Cuerpos de Heinz (8.8) 14
22 Cuerpos de hemoglobina H (8.9) 14
23 Dianocitos (8.9) 15
25 Cuerpos de Howell-Jolly (8.9) 16
26 Esquistocitos (8.10) 16
27 Esquistocitos abundantes (8.10) 17
29 Pseudotrombocitopenia por EDTA (8.12) 18
34 Linfoblastos (8.16) 20
35 Blastos tipo Burkitt (8.16) 21
36 Sombras de Gümprecht (8.17) 21
37 Leucemia mieloide crónica (8.17) 22
38 Leucemia linfática crónica (8.17) 22
41 Célula de Reed-Sternberg (8.18) 24
45 Pilas de monedas (rouleaux) (8.19) 26
48 Trombocitemia esencial (8.20) 27
49 Dacriocitos (8.20) 28
50 Neutrófilo pseudo-Pelger-Huët (8.20) 28

Esquema · 4

14 Prueba de Coombs directa e indirecta (8.7) 10
18 Patogenia de la esferocitosis (8.8) 12
28 Cascada de la coagulación y sus exámenes (8.11) 17
43 Electroforesis: pico monoclonal (8.19) 25

Imagen radiológica · 7

12 Degeneración combinada subaguda (8.6) 9
24 Cráneo en cepillo (8.9) 15
31 Hematoma del psoas en la TAC (8.13) 19
44 Lesiones líticas del mieloma (8.19) 25
52 Compresión medular por metástasis (8.22) 29
55 TRALI (8.24) 31
56 TACO (8.24) 31

Trazado (ECG / registro) · 1

51 ECG de hiperkalemia (8.22) 29

Ecografía · 1

19 Colelitiasis pigmentaria (8.8) 13

Endoscopía · 1

42 Linfoma MALT gástrico (8.18) 24

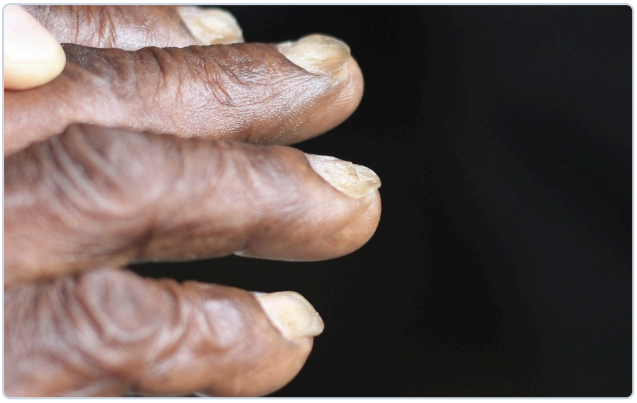
Pieza anatómica · 1

30 Artropatía hemofílica (8.13) 18

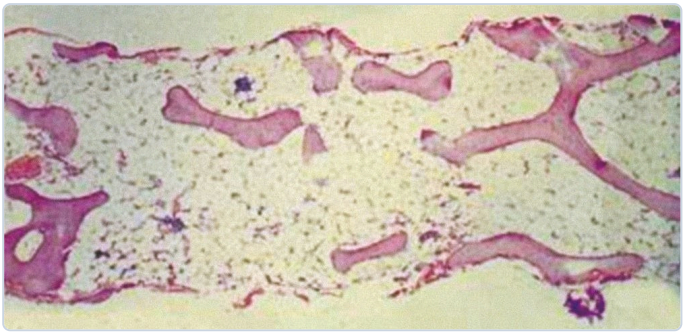
Autoevaluación

8 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

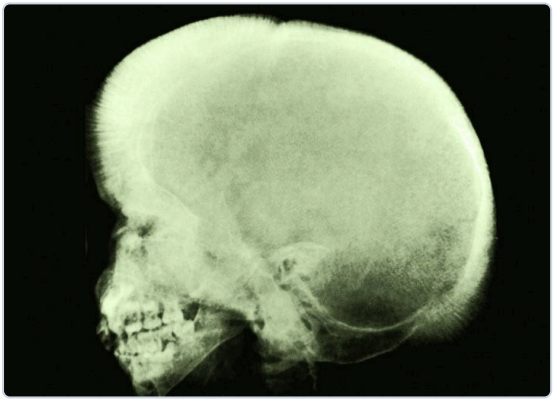
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



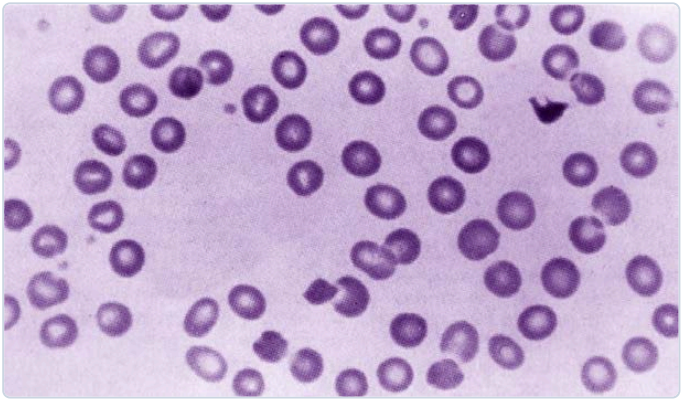
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



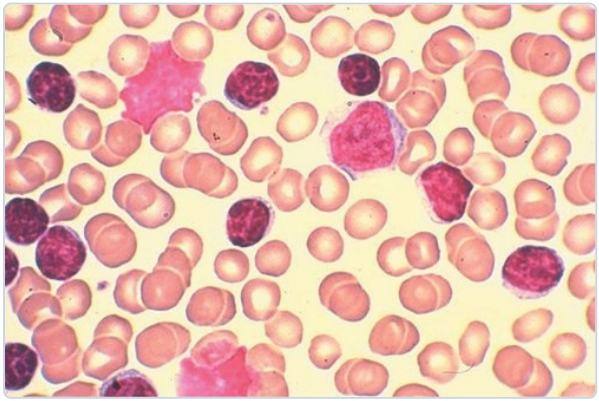
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



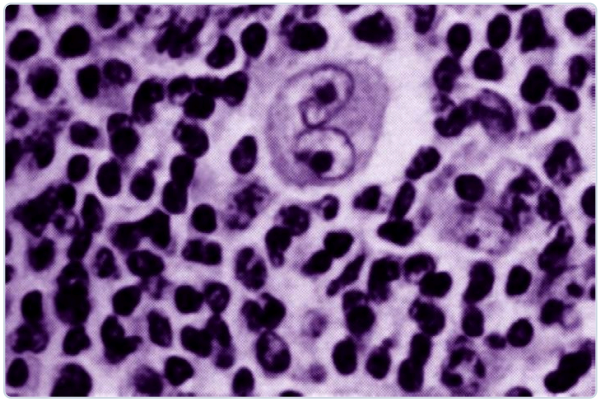
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



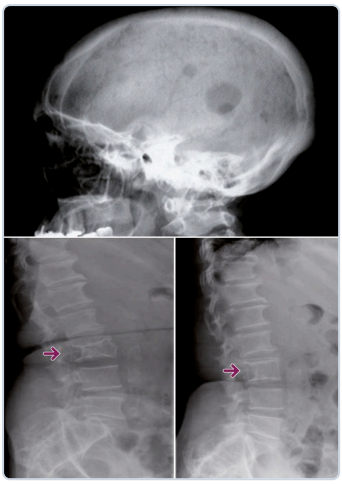
5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



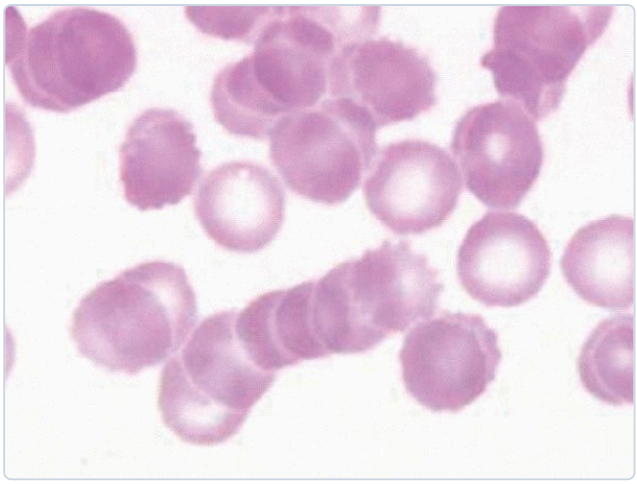
6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Coiloniquia**	Uña cóncava	04 · p. 5
2	**Aplasia medular**	Médula grasa, casi sin células	09 · p. 8
3	**Cráneo en cepillo**	Bóveda en cepillo	24 · p. 15
4	**Esquistocitos**	Esquistocito	26 · p. 16
5	**Sombras de Gümprecht**	Sombra de Gümprecht	36 · p. 21
6	**Célula de Reed-Sternberg**	Núcleos en espejo	41 · p. 24
7	**Lesiones líticas del mieloma**	Lesiones en sacabocado	44 · p. 25
8	**Pilas de monedas (rouleaux)**	Rouleaux	45 · p. 26